

ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS BERDASARKAN TINJAUAN 3N & 3S

(DILENGKAPI DENGAN KONSEP PENYAKIT DAN CONTOH KASUS)

Ns. T. Widya Naralia, M.Kep., Sp.Kep.K
Ns. Siti Mukaromah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Ns. Nurulistyawan Tri Purnanto, MNS
Achmad Ali Basri, S. Kep., Ns., M. Kep



**ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
BERDASARKAN TINJAUAN 3N & 3S
(DILENGKAPI DENGAN KONSEP PENYAKIT DAN CONTOH KASUS)**

**Ns. T. Widya Naralia, M.Kep., Sp.Kep.K
Ns. Siti Mukaromah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Ns. Nurulistyawan Tri Purnanto, MNS
Achmad Ali Basri, S. Kep., Ns., M. Kep**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
BERDASARKAN TINJAUAN 3N & 3S
(DILENGKAPI DENGAN KONSEP PENYAKIT DAN CONTOH KASUS)**

Penulis:

Ns. T. Widya Nalaria, M.Kep., Sp.Kep.K
Ns. Siti Mukaromah, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom
Ns. Nurulistyawan Tri Purnanto, MNS
Achmad Ali Basri, S. Kep., Ns., M. Kep

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah

ISBN: 978-623-09-3557-2

Cetakan Pertama:

Februari 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat**

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

PRAKATA

Bismillahirrohmanirohim

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala, atas berkat dan karunia-Nya Buku yang berjudul "Asuhan Keperawatan Komunitas Berdasarkan Tinjauan 3N & 3S" dapat kami selesaikan dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Perawat Komunitas di Indonesia sangat membutuhkan panduan penulisan asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan fenomena ataupun penyakit yang sering terjadi di masyarakat

Buku ini ditujukan bagi perawat, mahasiswa keperawatan maupun dosen keperawatan komunitas yang sedang mendalami tentang aplikasi asuhan keperawatan komunitas. Buku ini juga dilengkapi dengan kasus serta contoh penerapan asuhan keperawatan sesuai kasus yang dituliskan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Optimal yang telah membantu memfasilitasi dalam pembuatan buku referensi ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini. Besar harapan kami agar buku ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh perawat, mahasiswa keperawatan dan dosen keperawatan untuk memberikan dampak baik kepada masyarakat Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT LANSIA DENGAN DIABETES MELLITUS (DM).....	1
ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT ANAK USIA SEKOLAH (AUS) DENGAN ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI	29
ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT DEWASA DENGAN GAGAL GINJAL KRONIS (GGK).....	57
ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT DEWASA DENGAN TUBERKULOSIS (TB) PARU	83
SINOPSIS BUKU	97

ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT LANSIA DENGAN DIABETES MELLITUS (DM)



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Asuhan Keperawatan Komunitas pada Agregat Lansia dengan Diabetes Mellitus (DM)

A. Tujuan Penulisan

Setelah membaca topik asuhan keperawatan pada agregat lansia dengan DM maka pembaca mampu memahami tentang konsep penyakit Diabetes Mellitus (DM), proses asuhan keperawatan komunitas pada lansia dengan DM serta berbagai inovasi yang mendukung perawat komunitas dalam penatalaksanaan kelompok DM. Asuhan keperawatan komunitas ini disusun berdasarkan penulisan NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*), NOC (*Nursing Outcome Classification*) dan NIC (*Nursing Intervention Classification*).

B. Fenomena Diabetes Mellitus

Penyakit diabetes mellitus menduduki peringkat ke-6 sebagai penyakit penyebab kematian pada tahun 2018 (World Health Organization, 2018). *International Diabetes Federation* mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 7 sebagai negara dengan angka kejadian diabetes di dunia dengan kisaran penderitanya mencapai 10,7 juta jiwa (IDF, 2019). Bahkan IDF menyatakan terdapat 6,8-8,5 juta orang Indonesia dengan usia 20-79 tahun yang tidak terdiagnosa DM namun telah merasakan tanda gejala khas diabetes mellitus dan tidak menyadari hal tersebut. Bahkan data terbaru dari IDF (2021) menunjukkan bahwa Indonesia naik ke peringkat 5 sebagai negara dengan jumlah penderita DM terbanyak di dunia yang mencapai 19,5 juta orang penderitanya. Data tersebut menunjukkan angka kasus DM di Indonesia sangat tinggi dan harus segera ditangani.

Lansia memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan usia dewasa. Sebuah riset tentang usia sebagai faktor pemicu diabetes menunjukkan bahwa usia diatas 70 tahun berisiko terkena diabetes 7,4 kali lebih tinggi dibandingkan usia dibawahnya (Suastika, 2012). Saat ini Indonesia sudah mulai memasuki struktur penduduk tua atau *ageing population* dimana terdapat 10,7 % penduduk Indonesia berusia diatas 60 tahun ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2021). Terdapat 48,14% lansia di Indonesia yang mengalami keluhan kesehatan baik fisik maupun psikis dan 24,35% diantaranya dalam kondisi sakit yang didominasi dengan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, demensia, penyakit jantung, stroke dan reumatik ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2020). Mayoritas lansia berada di masyarakat baik tinggal bersama keluarganya maupun tanpa keluarga.

Perawat komunitas harus bekerja sama dengan keluarga sebagai *caregiver* (pelaku rawat) lansia agar keluarga sebagai pemberi asuhan mampu mencapai keberhasilan dalam asuhan anggota keluarga baik dalam keadaan sehat maupun sakit (Stanhope dan Lancaster, 2013). Ervin (2002) juga menyatakan bahwa perawat komunitas memandang

komunitas atau populasi sebagai fokus utama praktik keperawatan sehingga perawat sudah sepatutnya dapat mengidentifikasi pelaku rawat dalam keluarga sebagai *family at risk*. *Family at risk* adalah kelompok yang memiliki karakteristik tertentu untuk mengalami penyakit, cedera, atau masalah kesehatan (Clemen-Stone & McGuire, 2002). Contoh keluarga dengan risiko ialah keluarga yang memiliki kondisi sanitasi dasar yang buruk, hipertensi arteri sistemik, menderita penyakit diabetes mellitus dan kecanduan narkoba (Nakata et al., 2013). Keluarga dengan anggota keluarga lansia yang menderita diabetes merupakan keluarga yang berisiko, oleh karena itu keluarga sebagai pelaku rawat lansia dengan DM perlu diberikan edukasi kesehatan, pemantauan kesehatan dan peningkatan kemampuan dalam perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya.

Kebanyakan lansia menderita Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2) yaitu DM karena faktor pola hidup dan proses penuaan (Lee & Halter, 2017). Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap efek sekresi sel β insulin dan sensitivitas jaringan tubuh terhadap insulin. Terjadinya DMT2 pada lansia diperburuk dengan menurunnya fungsi multiorgan akibat proses degeneratif. Kondisi hiperglikemi yang berlangsung lama akan menyebabkan perburukan pada sistem peredaran darah, muskuloskeletal hingga mengganggu proses kognitif lansia dan menurunkan kualitas hidupnya (Lee & Halter, 2017; Paolisso, 2010)

Penyebab DM akibat proses penuaan tidak dapat dihentikan, hanya faktor pola hidup yang dapat diubah untuk mengurangi dampak perburukan akibat diabetes mellitus. Manajemen penatalaksanaan DM pada lansia meliputi beberapa hal yaitu peningkatan pengetahuan terkait DM, perubahan pola hidup dengan manajemen nutrisi, peningkatan aktivitas fisik yang sesuai, pengaturan stres serta kontrol kadar glukosa dalam darah (IDF, 2019; McClinchy, 2018). Berbagai upaya melaksanakan manajemen penatalaksanaan DM tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia melalui program-program di Puskesmas baik program untuk individu maupun untuk kelompok masyarakat.

C. Konsep Diabetes Mellitus

1. Definisi Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah melebihi dari nilai normalnya atau disebut hiperglikemi (Webber, 2021). Terdapat 2 cara pengukuran kadar glukosa darah yaitu ketika 2 jam setelah makan (tidak puasa) dan ketika puasa minimal 8 jam tanpa asupan makanan. Seseorang terindikasi mengalami DM ketika kadar Glukosa Darah Sewaktu (GDS) menunjukkan nilai ≥ 200 mg/dL dan kadar Glukosa Darah Puasa (GDP) menunjukkan nilai ≥ 126 mg/dL (PERKENI, 2019). Tingginya kadar glukosa dalam darah tersebut terjadi akibat tidak optimalnya kinerja dari hormon insulin yang disekresikan dari sel β di pankreas.

2. Etiologi dan Klasifikasi DM

Penyebab terjadinya DM ialah...

Adapun faktor risiko pencetus terjadinya DM terbagi menjadi 2 faktor utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah ialah: (1) Usia: seseorang berusia ≥ 40 tahun menyebabkan fungsi dari pankreasnya menurun dalam mensekresikan hormon insulin; (2) Keturunan: seseorang dengan orang tua yang menderita DM memiliki risiko 7 kali lebih tinggi terkena DM dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keturunan penderita DM; (3) Jenis kelamin: wanita berisiko lebih tinggi menderita DM dibanding pria,
- b. Faktor risiko yang dapat diubah ialah: (1) Gaya hidup meliputi kebiasaan makan, aktivitas fisik dan manajemen stres; (2) Berat badan berlebih yaitu IMT (Indeks Massa Tubuh) $> 25\text{Kg/m}^2$, terlebih lagi seseorang yang telah obesitas karena hal ini berpengaruh pada resistensi sekresi insulin; (3) Minimnya aktivitas fisik dan olahraga, setidaknya seseorang harus melakukan olahraga selama 15-30 menit sebanyak 5 kali sepekan untuk dapat mengurangi risiko terkena DM; (4) Memiliki penyakit Hipertensi dan kardiovaskuler; (5) Tinggi konsumsi gula, garam dan rendah serat; (6) Memiliki kadar kolesterol atau lemak dalam darah yang tinggi yaitu $> 200\text{ mg/dL}$; (7) Merokok dan mengonsumsi minuman keras, hal ini akan merusak sel-sel pada organ pankreas.

Penyakit DM secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Namun, lebih rinci terdapat 4 klasifikasi DM yang dapat dilihat pada tabel 2.1 (PERKENI, 2019).

Tabel 1.1 Klasifikasi Etiologi DM

KLASIFIKASI	DESKRIPSI DAN KARAKTERISTIK
DM Tipe 1	Terjadinya kerusakan pada Sel β (beta) yang berhubungan dengan defisiensi insulin dikarenakan faktor autoimun ataupun idiopatik. Biasanya DMT1 berhubungan erat dengan faktor keturunan dan telah terjadi sejak usia kanak-kanak serta tidak berhubungan dengan berat badan berlebih. Karakteristik penderita DMT1 ialah diderita sejak muda, bentuk badan cenderung kurus, dan harus mendapatkan suntikan insulin.

DM Tipe 2	Terjadinya resistensi insulin (tubuh tidak mampu merespon insulin sehingga sulit memecah glukosa dalam darah) dan tidak optimalnya kinerja dari Sel β (beta) pada pankreas. Hal ini sangat erat kaitannya dengan faktor gaya hidup yang buruk serta bentuk badan gemuk dan obesitas. Karakteristik penderita DMT2 ialah terdiagnosa pada usia dewasa hingga lansia, bentuk badan gemuk hingga obesitas, dan perawatan serta pengobatan secara bertahap mulai dari perubahan gaya hidup, mendapatkan obat tablet hingga jika semakin parah maka menggunakan suntikan insulin.
DM GESTASIONAL	Diabetes ini terdiagnosis pada wanita hamil trimester kedua atau ketiga dimana sebelum kehamilan tidak ada menderita DM. Hal ini terjadi berkaitan dengan sekresi hormon kehamilan yang berlebih sehingga menyebabkan ketidakseimbangan penggunaan hormon insulin dalam tubuh.
DM YANG BERKAITAN DENGAN PENYEBAB LAINNYA	- o Penyakit yang menyerang pankreas seperti pankreatitis atau fibrosis kistik - o Sindroma diabetes monogenik atau <i>maturity-onset diabetes of the young</i> (MODY) merupakan diabetes yang diwariskan secara dominan autosomal - o DM yang disebabkan oleh obat atau zat kimia misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS atau pasca transplantasi organ

3. Patofisiologi Diabetes Mellitus

Kegagalan sel beta pankreas dalam mensekresikan insulin serta terjadinya resistensi insulin pada sel otot dan hati menjadi hal utama penyebab terjadinya DM (PERKENI, 2020). Faktor keturunan, obesitas, konsumsi makanan tidak sehat menjadi penyebab kurangnya sensitivitas dari hormon insulin untuk diserap dalam sel-sel tubuh. Dapat dikatakan bahwa pankreas menjadi kerja terlalu berat dalam mensekresikan insulin untuk mengolah glukosa dalam darah hingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada insulin (Kaneto, 2015). Tidak optimalnya kinerja hormon insulin menyebabkan glukosa beredar di dalam darah dan tidak digunakan oleh sel-sel dalam tubuh. Oleh karena itu, sel-sel tubuh mengalami starvasi sel atau sel yang kelaparan karena tidak mendapatkan asupan dengan tepat.

4. Manifestasi Klinis

Secara global, para ahli telah menetapkan bahwa terdapat **tanda gejala utama** dari DM, khususnya DMT2 (IDF, 2019): (1) Poliuri atau sering buang air kecil; (2) Polifagia atau mudah merasa lapar; (3) Polidipsi atau mudah haus.

Tanda gejala tambahan lainnya ialah (Kementrian Kesehatan RI, 2017): (1) Berat badan pada mulanya obesitas secara bertahap menjadi menurun tanpa penyebab yang jelas; (2) Sering kesemutan pada kaki maupun tangan; (3) Kulit kering dan gatal terutama daerah kemaluan; (4) Luka sulit sembuh; (5) Mudah mengantuk dan lelah; (6) Pengelihan kabur hingga glukoma; (7) Neuropati atau kebas di kaki maupun tangan; (8) Impotensi pada pria serta mudah keputihan pada wanita.

5. Komplikasi DM

Komplikasi dari penyakit DM mencakupi berbagai organ dalam tubuh, hal ini disebabkan hiperglikemia merusak berbagai sel pada organ tubuh. Komplikasi akibat DM dapat terjadi pada makrovaskuler, mikrovaskuler maupun saraf atau neuropati. Komplikasi makrovaskuler terjadi pada organ jantung seperti meningkatnya resiko serangan jantung koroner, kemudian pada organ otak seperti stroke dan pada pembuluh darah seperti luka kronis serta osteoporosis maupun osteoarthritis pada tulang dan sendi. Komplikasi mikrovaskuler terjadi pada organ mata seperti glukoma, dan pada ginjal seperti kegagalan fungsi ginjal. Selain itu, keluhan neuropati pada klien dengan DM kerap terjadi pada bagian perifer yaitu telapak kaki dan telapak tangan (Kaneto, 2015; PERKENI, 2020).

6. Pemeriksaan Penunjang

Penyakit Diabetes memberikan dampak negatif pada seluruh organ tubuh, oleh karena itu pemeriksaan penunjang yang diperlukan pada berbagai organ yang telah menunjukkan adanya penurunan fungsinya. Beberapa pemeriksaan penunjang yang diperlukan ialah pemeriksaan fungsi ginjal, elektrokardiogram (EKG), rontgen thorax, pemeriksaan kaki secara komprehensif dan pemeriksaan darah lengkap termasuk profil lipid (Kaneto, 2015; PERKENI, 2020).

7. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan medis menjadi hak dari dokter dan kolaborasi dengan perawat. Klien yang telah terdiagnosa DM akan diberikan obat metformin dengan dosis yang telah ditentukan serta dalam pemantauan dokter. Menurut PERKENI (2020) tujuan dari penatalaksanaan diabetes ialah untuk meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Sedangkan tujuan khususnya ialah:

- a. Tujuan jangka pendek: menghilangkan keluhan yang dirasakan penderita DM serta memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi akut

- b. Tujuan jangka panjang: mencegah dan menghambat progresivitas penyulit dan komplikasi penyakit
- c. Tujuan akhir ialah untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas DM

D. Asuhan Keperawatan pada Kelompok Lansia dengan Diabetes Mellitus

Proses asuhan keperawatan komunitas pada dasarnya ialah sama yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Hal yang membedakan asuhan keperawatan komunitas dengan asuhan keperawatan lainnya ialah dalam hal pengkajian yang cukup luas mencakupi kondisi komunitas ataupun kelompok dengan menggunakan konsep komunitas sebagai mitra atau (*Community as Partner*). Perawat menjalankan asuhan keperawatan dengan strategi yang pemecahan masalah adalah melalui pendidikan dan promosi kesehatan, teknologi tepat guna, pendekatan budaya serta memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah.

1. Pengkajian Individu dan Kelompok

a. Pengkajian Individu

Pengkajian setiap individu dapat dilakukan dengan mengkaji fisik secara umum meliputi keluhan atau tanda gejala umum dan keluhan atau tanda gejala tambahan. Kemudian melakukan skrining kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, plasma darah yaitu kadar glukosa darah sewaktu (KGDS), kadar glukosa darah puasa (KGDP) serta HbA1c.

Seseorang dicurigai telah mengidap DM jika telah terlihat tanda gejala serta hasil pemeriksaan KGD berikut (Kementerian Kesehatan RI., 2020; PERKENI, 2020):

Tabel 2.1 Pemeriksaan Plasma Glukosa Darah

Pemeriksaan	Nilai Normal	Diabetes Mellitus
Glukosa Darah Puasa yaitu kondisi pemeriksaan plasma darah saat tidak ada asupan makanan minimal selama 8 jam. Klien hanya diperbolehkan mengkonsumsi air mineral	70-125 mg/dL	KGDP $\geq$ 126 mg/dL ditambah dengan gejala utama
Glukosa Darah Sewaktu yaitu kondisi pemeriksaan plasma darah saat tidak puasa atau konsumsi makanan sehari-hari	70-200 mg/dL	KGDS $>$ 200 mg/dL ditambah dengan gejala utama & tambahan
Pemeriksaan HbA1C yaitu pemeriksaan plasma darah yang dilakukan di	5-7 %	HbA1c $>$ 7 % ditambah dengan

laboratorium dan menggunakan metode pengambilan darah vena		gejala utama dan tambahan
--	--	---------------------------

Pengkajian dan pemeriksaan ini dilakukan pada setiap individu di masyarakat terutama pada lansia. Lansia dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan penyakit DM maka akan dikelompokkan menjadi 1 kelompok untuk kemudian dikelola dalam intervensi keperawatan komunitas. Pengkajian individu juga meliputi data demografik dan riwayat kesehatan keluarga, hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kemungkinan risiko prognosis penyakit diabetes mellitus.

Selain melakukan pengkajian dan pemeriksaan pada setiap individu, perawat juga dapat melakukan wawancara tentang pengetahuan, sikap serta keterampilan tentang perawatan diri diabetes pada setiap individu. Perlu diketahui bahwa prinsip intervensi keperawatan pada kelompok ialah mengutamakan kemandirian kelompok untuk merubah perilaku sehatnya yaitu adanya peningkatan pengetahuan, perubahan sikap serta peningkatan keterampilan menjadi lebih baik.

b. Pengkajian Keperawatan Komunitas

Pengkajian keperawatan komunitas menggunakan konsep dari *Community as Partner* (CAP) yaitu model keperawatan komunitas dalam bentuk pemetaan atau “mapping” yang menjelaskan batasan-batasan yang dibutuhkan perawat untuk mengkaji kondisi suatu komunitas atau masyarakat dalam satu tempat (Anderson & McFarlane, 2014). Model CAP akan memberikan arahan kepada perawat tentang hal-hal apa saja yang perlu dikaji mendalam untuk mendapatkan data secara lengkap serta mendapatkan masalah dalam satu kelompok masyarakat.

Model *Community as Partner* terbagi menjadi 3 topik utama yaitu inti komunitas (*core*), subsistem komunitas (*the community subsystem*) dan persepsi (*perception*). Ketiga topik tersebut dijabarkan lagi menjadi menjadi lebih spesifik, namun pengkajian tersebut tidak harus seluruhnya digunakan, perawat sebagai tenaga kesehatan profesional dapat memilih item pengkajian yang tepat untuk digunakan pada kelompok masyarakat yang akan dikajinya. Proses pengkajian dilakukan dengan anamnesa kepada tokoh masyarakat setempat dan melakukan observasi atau windshield survey di daerah binaan.

1) Data Inti (Core)

Data inti yang dikaji oleh perawat meliputi sejarah atau riwayat daerah dan perubahan daerah, kemudian demografi, karakteristik, umur dan sex,

serta vital statistic. Data yang dikaji mencakupi seluruh masyarakat di daerah binaan, seperti persentase lansia dengan diabetes dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk lansia baik yang telah terdiagnosa DM ataupun belum, kemudian rata-rata usia lansia, etnis atau suku di wilayah tersebut serta keyakinan dan budaya/ kebiasaan atau keyakinan lansia di daerah tersebut.

Contoh:

“Terdapat 60% lansia dengan DM di Desa XX dengan rata-rata usia 67 tahun dan 70%nya berjenis kelamin wanita. Adapun kebiasaan lansia DM di Desa XX ialah terbiasa mengkonsumsi kopi dan teh manis, budaya di Desa XX meyakini bahwa teh manis harus dikonsumsi setiap hari”

2) Data sub sistem

Data subsistem terdiri menjadi 8 hal yaitu (1) lingkungan fisik, (2) pendidikan, (3) transportasi, (4) politik dan pemerintah, (5) fasilitas kesehatan & sosial, (6) komunikasi, (7) perekonomian, 8) Rekreasi. Ke-delapan poin dalam subsistem ini tidak wajib semua dilakukan pengkajian. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional berhak untuk menentukan item pengkajian apa yang paling tepat untuk dikaji agar mengetahui penyebab masalah kesehatan yang sebenarnya.

Contoh:

Hasil pengkajian masyarakat di Desa XX ialah:

- (1) **Lingkungan fisik** berkaitan dengan kesehatan lingkungan termasuk lingkungan sekitar di keluarga. Paparan virus, bakteri hingga polusi dapat menyebabkan kerusakan pankreas sehingga memungkinkan terjadinya penyakit diabetes.
- (2) **Pendidikan** pada umumnya akan memberikan gambaran tentang pengetahuan seseorang termasuk tentang pola hidup sehat yang berkaitan dengan penyakit DM. Namun sebuah penelitian tentang hubungan pendidikan dengan kejadian DM menunjukkan bahwa seseorang dengan pendidikan tinggi memiliki angka kejadian DM yang lebih tinggi pula di wilayah masyarakat kota (Safitri et al., 2021).
- (3) **Transportasi** erat hubungannya dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai akses ke fasilitas kesehatan, serta sebagai sarana pendukung mendapatkan informasi tentang DM
- (4) **Politik dan Pemerintah** erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya ialah peraturan tentang pemantauan kesehatan pada lansia karena berisiko tinggi menderita penyakit degeneratif dan kronis seperti diabetes

- (5) **Fasilitas Kesehatan & Sosial** sangat erat kaitannya terhadap penyakit DM. Ketersediaan faskes seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit di sekitar masyarakat perlu untuk dikaji
- (6) **Komunikasi** erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan pesan terutama tentang masalah kesehatannya. Selain itu komunikasi juga berkaitan dengan informasi kesehatan yang beredar di masyarakat terkait dengan masalah penyakit DM
- (7) **Perekonomian** sangat erat kaitannya dengan kejadian dan proses pemeliharaan penyakit DM seorang lansia. Salah satu contohnya ialah status perekonomian yang cukup dapat mendukung pemenuhan nutrisi sehat, suplemen makanan, dan sejenisnya. Namun perekonomian yang sulit tidak dapat dijadikan alasan hambatan dalam peningkatan perilaku sehat bagi lansia DM.
- (8) **Rekreasi** menjadi hal yang mungkin kurang krusial, namun hal ini dapat mendukung data tentang ketersediaan wahana untuk relaksasi bagi masyarakat setempat.

3) Data Persepsi

Data ini berkaitan dengan persepsi masyarakat dan persepsi perawat. Hal yang perlu dikaji pada poin persepsi ini ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyakit DM yang dideritanya serta bagaimana pandangan perawat terhadap kemampuan meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Contoh:

- Persepsi Masyarakat: Adanya pandangan bahwa penyakit DM sangat sulit disembuhkan, dan jika mengkonsumsi obat-obatan maka akan menyebabkan ketergantungan bahkan menyebabkan gagal ginjal.
 - Data yang telah diperoleh dapat menjadi dasar bagi perawat untuk melakukan strategi pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah persepsi yang salah tersebut.
- Persepsi Perawat: Perawat melihat kurangnya motivasi masyarakat, serta sulitnya masyarakat untuk kooperatif dalam menjalankan perawatan DM
 - Data ini juga dapat membantu agar perawat melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat

CONTOH KASUS A

Desa XX terletak di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 100 orang lansia yang telah terdiagnosa DM. Rata-rata usia ialah 69 tahun dengan persentase lansia laki-laki 55% dan lansia perempuan 45%. Rata-rata lansia telah mengidap diabetes mellitus selama 4 tahun dan sebanyak 30% sudah mengalami komplikasi seperti neuropati, glukoma dan lainnya. Sebanyak 90% lansia berpendidikan sekolah dasar dan hanya 10% nya yang berpendidikan perguruan tinggi. Terdapat 1 puskesmas pembantu di Desa XX yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Akses ke Desa XX dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan yang cukup baik.

Desa XX merupakan desa penghasil buah durian, masyarakatnya memiliki kebiasaan konsumsi buah tersebut ditambah dengan pola makan yang kurang tepat seperti terbiasa konsumsi makanan digoreng berulang kali. Selain itu masyarakat Sumatera Barat memiliki kebiasaan konsumsi makanan bersantan dan menjadi ciri khas makanan di Sumatera Barat. Kebiasaan konsumsi makanan bersantan sangat sulit diubah diakui oleh masyarakat, ditambah lagi kurangnya aktivitas fisik lansia karena sulit berjalan dan sebagian besar telah menggunakan alat bantu tongkat. Lansia di Desa XX juga tidak pernah mengikuti senam kelompok yang ada di Kantor Kepala Desa karena senam yang diajarkan merupakan senam aerobik yang tidak mampu diikuti oleh lansia. Seluruh lansia sudah tidak bekerja dan sehari-hari mengisi aktivitas dengan interaksi sosial di wilayah sekitaran rumah.

Selain kebiasaan dan gaya hidup lansia yang buruk, lansia juga tidak patuh dalam mengkonsumsi obat untuk penyakit DM. Lansia memiliki persepsi bahwa jika mengkonsumsi obat secara terus menerus maka akan menyebabkan kerusakan ginjal. Mitos yang beredar di masyarakat tersebut menyebabkan lansia tidak kontrol ke puskesmas ataupun pelayanan kesehatan lainnya.

2. Diagnosa Keperawatan

Penentuan diagnosa keperawatan komunitas juga berdasarkan masalah paling prioritas yang ditemukan pada kelompok. Pemilihan prioritas diagnosa keperawatan komunitas menurut Ervin (2002) didasarkan pada pertimbangan:

- 1) Seberapa penting masalah untuk diselesaikan (Skor: 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi)
- 2) Perubahan positif pada komunitas bila masalah diselesaikan (Skor 0 tidak ada perubahan, skor 1 perubahan rendah, skor 2 perubahan sedang, skor 3 perubahan tinggi)
- 3) Peningkatan kualitas hidup jika masalah diselesaikan (skor 0 tidak ada peningkatan, skor 1 peningkatan Kualitas hidup/ *Quality of Life* (QoL) rendah, skor 2 peningkatan QoL sedang, skor 3 peningkatan QoL tinggi)
- 4) Peringkat semua masalah (skor 1 (kurang penting) – 6 (sangat penting))

Tabel 2.2 Diagnosa keperawatan komunitas terhadap kasus A

Diagnosa Keperawatan	Komponen Skor				Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Ketidakefektifan Manajemen Mandiri kesehatan terkait penyakit DM (NANDA: 00276)	3	2	2	6	13
Sindrom lansia lemah (NANDA: 00257)	3	3	2	5	12
Defisien Kesehatan Komunitas (NANDA : 00215)	3	2	2	4	11

Diagnosa prioritas yang dilaksanakan diurutkan berdasarkan hasil skor tertinggi ke skor terendah, yaitu:

- 1) Ketidakefektifan manajemen mandiri kesehatan : diabetes mellitus (NANDA: 00276)
- 2) Sindrom lansia lemah (NANDA: 00257)
- 3) Defisien Kesehatan Komunitas (NANDA: 00215)

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada kelompok berorientasi pada tindakan pencegahan secara primer, sekunder dan tersier. Adapun penjelasan dari ketiga pencegahan tersebut ialah sebagai berikut (CDC, 2015) :

- a. **Pencegahan primer** atau *primary prevention* merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada saat penyakit atau masalah kesehatan belum terjadi dengan tujuan agar tidak terjadi masalah kesehatan tersebut. Contohnya melakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit,
- b. **Pencegahan sekunder** atau *secondary prevention* merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada tahapan awal sebelum munculnya tanda gejala dengan tujuan agar proses penyakit tidak berlanjut. Pencegahan sekunder juga bertujuan deteksi dini atau skrining kesehatan untuk menjangkau data kelompok yang berisiko terserang masalah kesehatan. Contohnya swab massal pada kelompok masyarakat untuk menjangkau data yang telah terinfeksi Covid-19, tindakan mamografi untuk mendeteksi kanker payudara, skrining tekanan darah dan kadar glukosa darah untuk mendeteksi penyakit DM.
- c. **Pencegahan tersier** atau *tertiary prevention* merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan ketika penyakit atau masalah kesehatan telah terjadi dengan tujuan untuk memperlambat atau mengurangi komplikasi dari penyakit tersebut serta untuk mencegah terjadinya kecacatan. Contohnya tindakan kemoterapi pada kondisi penyakit kanker, rehabilitasi pasca stroke.

Strategi intervensi keperawatan komunitas dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantara lain melalui (Ervin,2002) :

- Intervensi keperawatan yang disusun dalam tabel perencanaan atau *Nursing Care Plan (NCP)* dari Contoh Kasus A dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
1.	<u>Data Subjektif</u> Lansia menyatakan - Tidak mampu mengatur pola makan dan porsi makanan yang tepat - tidak mengkonsumsi obat	Ketidakefektifan Manajemen Mandiri Kesehatan (NANDA: 00276)	1619 161901 161907 161908 161909	<u>Prevensi Sekunder</u> Manajemen Diri : Diabetes Setelah diberikan tindakan diharapkan adanya peningkatan dari skala 1 yaitu tidak pernah menunjukkan menjadi skala 4 yaitu sering menunjukkan dengan kriteria hasil:	5602 5614 5615	Prevensi Sekunder Pengajaran Proses Penyakit: Diabetes Mellitus Pengajaran Peresepan Diet: Makanan bagi penderita DM

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	secara teratur • gemar mengonsumsi kopi, teh manis, susu kental manis dan sering mengonsumsi gorengan • Jarang berolahraga karena merasa bahwa aktivitas sehari-hari sudah melelahkan dan sudah termasuk olahraga <u>Data</u> <u>Objektif</u> <u>Hasil observasi:</u> • Sebanyak 67% lansia		• 161910 • 161915 • 161916 • 161920 • 161924 • 161927 • 161942 • 1600 • 160002 • 160003	• Menerima Diagnosis • Berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kesehatan • Berpartisipasi aktif dalam program edukasi yang dianjurkan • Menjalani aturan pengobatan sesuai resep • Melakukan prosedur yang benar untuk pengecekan gula darah • Melaporkan gejala komplikasi • Menggunakan catatan harian untuk monitor kadar gula darah dari waktu ke waktu • Mengikuti diet yang disarankan • Mempertahankan berat	5616 6520 8510 8500	Pengajaran Peresepan Latihan: Aktivitas Fisik dirumah bagi lansia DM Pengajaran Peresepan Obat-obatan: Obat DM dan Hipertensi Skrining Kesehatan Prevensi Tersier

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	memiliki sikap kurang baik tentang perawatan diri diabetes - Sebanyak 70% lansia memiliki keterampilan kurang dalam perawatan diri diabetes - Sebanyak 67% lansia memiliki tekanan darah tinggi (hipertensi) - Sebanyak 70% lansia memiliki kadar gula darah sewaktu		160008 160009 160012 160014	badan yang optimal - Ber partisipasi dalam olahraga yang direkomendasikan - Menyesuaikan kehidupan rutin untuk kesehatan yang optimal <u>Prevensi Tersier</u> Perilaku Patuh (bersifat aktif) Setelah diberikan tindakan diharapkan adanya peningkatan dari skala 1 yaitu tidak pernah menunjukkan menjadi skala 4 yaitu sering menunjukkan dengan kriteria hasil: - Mencari informasi kesehatan dari berbagai sumber		Dukungan Kesehatan Komunitas Pengembangan Kesehatan Komunitas

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	lebih dari 200mg/dL • Kebanyakan lansia gemar konsumsi makanan kurang sehat • Beberapa lansia yang sering membeli obat tanpa konsultasi ke dokter			• Menggunakan informasi kesehatan yang dapat dipercaya untuk mengembangkan strategi • Menggunakan strategi untuk mengeliminasi perilaku tidak sehat • Menggunakan berbagai strategi untuk mengoptimalkan kesehatan • Melakukan skrining sendiri • Melakukan monitor sendiri mengenai status kesehatan secara mandiri		
2.	Data Subjektif <u>Lansia menyatakan :</u> • Mengalami	Sindrome Lansia Lemah (NANDA: 00257)	1637 • 1637 03	Prevensi Sekunder: Partisipasi Rehabilitasi Muskuloskeletal Setelah diberikan tindakan	668 0	Prevensi Sekunder Monitor Tanda-Tanda Vital: Terkait

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	<u>Hasil observasi diperoleh:</u> • Sebanyak 12 orang lansia menggunakan alat bantu tongkat dalam berjalan dan beraktivitas sehari-hari • Rata-rata seluruh lansia terlihat tidak mampu berdiri dalam waktu lama (>15 menit) • Kebanyakan lansia sudah mengalami penurunan kekuatan otot serta			rentang aktivitas dan pergerakan aktif dari tubuh • Mampu memonitor kekuatan otot • Menggunakan strategi untuk mencegah jatuh • Menggunakan strategi untuk mencegah komplikasi • Melaporkan adanya kemajuan dalam rehabilitasi muskuloskeletal		

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	adanya penurunan sensitivitas kaki • Tidak adanya kegiatan latihan fisik bagi kelompok lansia dengan kelemahan tungkai					
3.	Data Subjektif <u>Lansia menyatakan</u> : • tidak mau mengkonsumsi obat karena takut akan terkena sakit ginjal • kebiasaan mengkonsumsi kopi kemasan setiap	Defisien Kesehatan Komunitas (NANDA: 00215)	2015 • 2015 01 • 2015 02 • 2015 04 • 2015 08	Prevensi Sekunder Perilaku Memahami Kesehatan Setelah diberikan tindakan diharapkan adanya peningkatan dari skala 1 yaitu tidak pernah menunjukkan menjadi skala 4 yaitu sering menunjukkan dengan kriteria hasil: • Mengidentifikasi kebutuhan	5450 4360	Prevensi Sekunder Terapi Kelompok: Lansia Diabetes Modifikasi Perilaku: Memahami dan Mampu Mengambil Keputusan terkait Perawatan DM

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	hari tidak menjadi masalah karena tidak menggunakan gula - lansia yang patuh mengkonsumsi obat, namun lebih sering membeli obat di apotek daripada konsul ke dokter sehingga dosis ditetapkan sendiri <u>Data</u> <u>Objektif</u> <u>Hasil</u> <u>observasi</u> <u>diperoleh:</u> - Tidak ada wadah lansia		2015 11 2015 13 2015 17 2015 20	kesehatan pribadi - Mendapatkan informasi kesehatan yang bereputasi - Memverbalisasikan pemahaman tentang kesehatan - Mengevaluasi informasi kesehatan yang didapatkan - Melengkapi dokumen terkait kebutuhan pelayanan kesehatan - Mengidentifikasi pelayanan kesehatan - Mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai - Menginformasikan keputusan mengenai perawatan kesehatan		

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	dengan DM untuk berdiskusi satu sama lain • Banyaknya tersebar mitos di masyarakat sehingga lansia DM sering salah mengambil keputusan • Beberapa lansia kesulitan mengambil keputusan untuk perawatan yang dilakukan karena terpengaruh oleh					

No	Data	Diagnosa Keperawatan	NOC		NIC	
			Kode	Hasil	Kode	Intervensi
	berita hoax					

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat oleh perawat. Implementasi keperawatan komunitas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, adanya kemandirian dan kesejahteraan, melakukan pencegahan terjadinya komplikasi penyakit dan manajemen maupun kontrol masalah kesehatan (Maglaya, 2009). Dalam melakukan implementasi kelompok, perawat perlu melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan sebagai bagian dari penggerak.

Implementasi keperawatan komunitas dapat dilakukan melalui strategi intervensi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan implementasi keperawatan dapat dilakukan melalui promosi kesehatan, demonstrasi, observasi dan kolaborasi.

- **Promosi Kesehatan**

Pelaksanaan promosi kesehatan atau edukasi kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan media edukasi seperti poster atau video audiovisual. Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan promosi kesehatan pada lansia ialah kemampuan kognitif dari lansia yang telah menurun sehingga menyampaikan materi harus perlahan, kemudian kemampuan mendengar yang telah berkurang serta konsentrasi yang menurun.

Berikut implementasi keperawatan dari **Kasus A** :

- Pengajaran proses penyakit: Diabetes Mellitus (NIC: 5602)
- Pengajaran persepan diet: Makanan bagi penderita DM (NIC: 5614)
- Pengajaran persepan latihan aktivitas fisik di rumah bagi lansia DM (NIC: 5615)
- Pengajaran persepan obat-obatan: DM (NIC: 5616)

- **Demonstrasi**

Pelaksanaan demonstrasi ini ialah perawat harus mencontohkan dan melakukan suatu aktivitas agar diikuti oleh lansia DM. Berikut implementasi keperawatan dari Kasus A:

- Terapi latihan mobilitas sendi: Lansia dengan DM (NIC: 0224)
- Peningkatan latihan peregangan (NIC: 0202)
- Terapi Kelompok: Lansia DM (NIC: 5450)

d. Modifikasi perilaku: memahami & mampu mengambil keputusan perawatan DM (NIC: 4360)

- **Observasi / Pemantauan kesehatan**

Pemantauan kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk tindakan skrining kesehatan:

Berikut implementasi keperawatan dari Kasus A:

- a. Skrining kesehatan: pengecekan tekanan darah dan KGDS (NIC: 6520)
- b. Monitoring tanda-tanda vital: berkaitan dengan DM (NIC: 6680)

- **Kolaborasi**

Kolaborasi dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dan memberikan dukungan agar adanya peningkatan status kesehatan kelompok. Beberapa implementasi keperawatan dari Kasus A:

- a. Dukungan kesehatan komunitas (NIC: 8510)
- b. Pengembangan Kesehatan Komunitas: kemitraan (NIC: 8500)

Pelaksanaan implementasi keperawatan komunitas atau kelompok harus dilakukan secara bertahap, terbinanya hubungan saling percaya dan adanya motivasi dari kelompok untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kedekatan terhadap kelompok yang dibina, serta memiliki hubungan yang baik terhadap tokoh masyarakat setempat sebagai sistem pendukung kelompok binaannya.

Berikut ini contoh *Plan of Action* (PoA) dalam menjalankan salah satu implementasi:

No.	Masalah	Tujuan	Kegiatan	Tempat	Waktu	PJ
1.	Ketidakefektifan Manajemen Mandiri Kesehatan (NANDA: 00276)	Setelah diberikan tindakan diharapkan adanya peningkatan dari skala 1 yaitu tidak pernah menunjukkan menjadi skala 4 yaitu sering menunjukkan dengan	Pengajaran proses penyakit: Diabetes Mellitus (NIC: 5602) a. Membuka pertemuan kelompok b. Identifikasi kemampuan kelompok c. Memberikan edukasi tentang penyakit DM d. Memberikan kesempatan	Majelis taklim Desa XX	Rabu Pekan ke-2 setelah pengajian lansia	Perawat Desa XX

		kriteria hasil yang telah ditentukan	lansia untuk bertanya e. Memberikan umpan balik f. Melakukan evaluasi materi			
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan dapat berupa evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dapat dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada kelompok, apakah sesuai dengan target yang direncanakan atau belum sesuai. Hal yang dapat dinilai dari evaluasi proses ialah lansia DM berkomitmen dan bersedia mengikuti kegiatan mulai dari awal hingga akhir, kemudian lansia antusias pada kegiatan yang dilaksanakan.

Evaluasi hasil dapat dilihat sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan diawal. Hal yang dapat dinilai dari evaluasi hasil ialah lansia mampu menjelaskan kembali tentang proses penyakit DM, lansia mengulang kembali tentang tanda gejala penyakit DM, lansia mampu mengambil keputusan untuk menentukan makanan sehat bagi dirinya sebagai penderita DM, dan sebagainya sesuai dengan target kriteria hasil.

*"Setiap perjuangan pasti ada hasilnya.
Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan."*

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Lansia. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย*, 4(1), 88–100.
- Anderson, E. T., & McFarlane, J. (2014). Community as partner: Theory and practice in nursing. In *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*. <https://doi.org/10.1097/00000446-199610000-00015>
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & M.Wagner, C. (2013). Nursing Interventions Classification (NIC). Jakarta: Mocomedia.
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & M.Wagner, C. (2013). Nursing Outcome Classification (NOC). Jakarta: Mocomedia.
- CDC. (2015). *What is prevention?*
- Ervin, N.E. (2002). Advanced community health nursing practice. Upper Saddle River- New Jersey: Prentice Hall.
- Herdman, T. H. dan S. K. (2018). Nanda Internasional Diagnosis Keperawatan: Definisi dan Klasifikasi 2018-2020 (Edisi 11). Jakarta: EGC.
- IDF. (2019). International Diabetes Federation. In *The Lancet* (Vol. 266, Issue 6881). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(55\)92135-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(55)92135-8)
- Kaneto, H. (2015). Pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. In *Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine* (Vol. 73, Issue 12, pp. 2003–2007). <https://doi.org/10.1093/med/9780199235292.003.1336>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Infodatin tetap produktif, cegah, dan atasi Diabetes Melitus 2020. In *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* (pp. 1–10).
- Kementrian Kesehatan RI. (2017). *Pencegahan Diabetes Mellitus*.
- Lee, P. G., & Halter, J. B. (2017). The pathophysiology of hyperglycemia in older adults: Clinical considerations. *Diabetes Care*, 40(4), 444–452. <https://doi.org/10.2337/dc16-1732>
- McClinchy, J. (2018). Dietary management of older people with diabetes. *British Journal of Community Nursing*, 23(5), 248–251. <https://doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.5.248>
- Nakata, P. T., Koltermann, L. I., Vargas, K. R. de, Moreira, P. W., Duarte, Ê. R. M., & Rosset-Cruz, I. (2013). Classification of family risk in a Family Health Center. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 21(5), 1088–1095. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692013000500011>
- Paolisso, G. (2010). Pathophysiology of diabetes in elderly people. *Acta Biomedica*, 81(SUPPL. 1), 47–53.
- PERKENI. (2020). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2

- Dewasa di Indonesia 2015. (2015). PB PERKENI. *Global Initiative for Asthma*, 46. www.ginasthma.org.
- PERKENI, et all. (2019). Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia. *Perkeni*, 133.
- Safitri, A. Z., Fajariyah, R. N., & Astutik, E. (2021). Risk Factors of Diabetes Mellitus in Urban Communities in Indonesia (IFLS 5). *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.20473/jbe.v9i22021.184-191>
- Suastika, et al. (2012). Age is an Important Risk Factor for Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Diseases. In *Glucose Tolerance*. <https://doi.org/10.5772/52397>
- Webber, S. (2021). International Diabetes Federation. In *Diabetes Research and Clinical Practice* (Vol. 102, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.10.013>
- World Health Organization. (2018). WHO - The top 10 causes of death. In *24 Maggio* (pp. 1–7). <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

**ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
PADA AGREGAT ANAK USIA SEKOLAH (AUS)
DENGAN ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI**



Asuhan Keperawatan Komunitas pada Agregat Anak Usia Sekolah (AUS) dengan Anemia Defisiensi Zat Besi

A. Tujuan Penulisan

Setelah membaca topik asuhan keperawatan pada anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi maka pembaca mampu memahami tentang konsep anemia defisiensi besi, proses asuhan keperawatan komunitas pada anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi serta berbagai inovasi yang mendukung perawat komunitas dalam penatalaksanaan kelompok anak usia sekolah. Asuhan keperawatan komunitas ini disusun berdasarkan penulisan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

B. Fenomena Defisiensi Zat Besi

Anak usia sekolah memiliki rentang usia 6-12 tahun (Edelman, Carole Lium; Mandle, Carol Lynn; and Kazer, 2006). Periode usia tersebut merupakan masa laten tahap perkembangan anak yang menunjukkan karakteristik tersendiri guna mempersiapkan peran tahap perkembangan selanjutnya yaitu pada masa remaja dan terlepas dari peran usia sebelumnya di masa pra sekolah. Pada masa ini terjadi percepatan proses perkembangan yang dialami yaitu aspek fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia, 2004). Tiap aspek perkembangan tersebut membuat anak usia sekolah berisiko terhadap masalah kesehatan.

Masalah kesehatan pada anak usia sekolah diantaranya terkait dengan kebutuhan nutrisi yang sangat berperan dalam perkembangan fisik maupun kognitif. Nutrisi dibutuhkan anak usia sekolah sebagai asupan energi untuk mendukung pertumbuhan dan aktifitas fisik maupun otak (Papalia, 2004). Salah satu komponen nutrisi yang dibutuhkan anak usia sekolah berupa asupan zat besi yang mendukung proses pembentukan sel darah merah dan metabolisme di dalam tubuh. Kekurangan zat besi dapat mempengaruhi perkembangan mental dan kemampuan kognitif anak usia sekolah, sehingga masa anak usia sekolah merupakan masa yang paling kritis terjadinya anemia defisiensi besi akibat asupan zat besi yang belum sepenuhnya terpenuhi (Miller & Rosso, 2009).

Data global WHO menyebutkan bahwa jumlah penderita anemia akibat defisiensi besi sebanyak 30% dari total populasi di dunia dan sebanyak 37% dari total penderita anemia akibat defisiensi besi tersebut adalah anak usia sekolah. Adapun prevalensi anak usia sekolah yang menderita Anemia defisiensi besi dari total populasi sejumlah 33% (Rani & Bandrapalli, 2017). Data tersebut menggambarkan bahwa anemia defisiensi besi merupakan salah satu masalah nutrisi yang mengancam perkembangan anak usia sekolah. Kondisi ini juga menggambarkan adanya asupan zat besi yang tidak adekuat,

malnutrisi, atau kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi (Djokic et al., 2010).

Menurut data WHO, prevalensi anak usia sekolah yang mengalami anemia defisiensi besi di Indonesia sejumlah 37-73% (Rani & Bandrapalli, 2017). Prevalensi anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah berdasarkan Riskesdas tahun 2013 sebesar 26,4% (Putri et al., 2021) Data prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia tersebut jika berdasarkan standar WHO terkait klasifikasi anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat yang penting tergolong pada kategori sedang (rentang prevalensi sebesar 20-39,9%) (McLean et al., 2009).

C. Konsep Penyakit Defisiensi Zat Besi (Anemia)

1. Definisi Defisiensi Zat Besi

Anemia defisiensi besi adalah kondisi kekurangan zat besi yang digunakan untuk sintesis hemoglobin (Hb), sehingga menyebabkan pembentukan sel darah merah yang terjadi dalam sumsum tulang (eritropoesis) terganggu (Fitriany & Saputri, 2018). Anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah merupakan gangguan keseimbangan nutrisi yang terjadi pada tahap perkembangan anak usia 6-12 tahun akibat tidak tercukupinya salah satu nutrisi berupa zat besi dalam tubuh. Adapun kadar zat besi menurut WHO bagi anak usia sekolah sebesar $\geq 11,5$ g/dl (Welfare, 2013).

2. Etiologi Defisiensi Zat Besi

Anemia defisiensi besi disebabkan oleh kekurangan zat besi yang merupakan elemen penting untuk mensintesis hemoglobin. Fungsi utama hemoglobin adalah membawa oksigen masuk ke dalam jaringan dan karbondioksida keluar dari jaringan, sehingga proses metabolisme tubuh dapat berlangsung optimal, selanjutnya mempengaruhi respon positif seluruh sistem tubuh termasuk aspek kognitif, motorik, dan daya tahan tubuh. Ada dua bentuk zat besi yaitu *heme* dan *non-heme*. Zat besi *heme* mudah diabsorpsi oleh tubuh dan terdapat pada daging merah maupun organ hewan (hati, limpa, dan ginjal). Zat besi *non-heme* tidak mudah diabsorpsi oleh tubuh dan terdapat pada kacang polong, padi-padian, sayuran hijau, dan gandum. Absorpsi *non-heme* perlu dibantu konsumsi makanan kaya vitamin C yang dilakukan bersamaan dengan konsumsi makanan yang mengandung zat besi *non-heme*.

Penyebab anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah, antara lain: jumlah zat besi tidak mencukupi dalam makanan, kehilangan zat besi karena beban parasit (misalnya cacingan), sanitasi lingkungan yang buruk, air minum yang tidak aman dan *personal hygiene* yang tidak memadai (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022). Kebiasaan jajan dan pola makan yang tidak sehat juga dapat menyebabkan

anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah. Kebiasaan suka jajan daripada makan di rumah dan pola makan yang tidak sehat dianggap wajar, padahal telah banyak informasi kesehatan terkait jajanan bahwa tidak semua jajanan yang diperjual belikan memenuhi standar keamanan pangan.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah adalah aktifitas fisik yang berkaitan dengan pola istirahat. Perkembangan kognitif, motorik, sosial maupun emosional yang dialami anak usia sekolah menyebabkan anak banyak bergerak daripada istirahat. Rasa penasaran terhadap kegiatan yang belum dilakukan ataupun rasa senang yang dialami terhadap kegiatan yang dilakukan membuat anak terus belajar dan bergerak, bahkan melebihi kemampuan fisiknya. Ketertarikan berkelompok dengan teman sejenis juga mendukung aktifitas yang dilakukan secara berlebihan (Hockenberry, Marilyn J.; Rodgers, Cheryl C.; Wilson, 2017).

Infeksi cacingan juga menyebabkan anemia. Tingginya prevalensi cacingan pada anak usia sekolah memberikan peluang besar terhadap risiko anemia (Sirajuddin & Masni, 2015). Infeksi cacingan berbahaya pada mukosa usus, mengakibatkan peradangan dan perdarahan, sehingga terjadi defisiensi besi.

3. Patofisiologi Defisiensi Zat Besi

Anemia defisiensi besi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan memiliki tahapan proses sebagai berikut:

a. Tahap pertama, yaitu deplesi besi (Iron depletion atau store iron deficiency)

Pada tahap ini tidak tampak gejala yang ditunjukkan, namun cadangan besi mengalami pengurangan, terjadi peningkatan absorpsi besi *non-heme* dan penurunan *ferritin serum* akibat peningkatan penyerapan zat besi oleh mukosa usus, sedangkan hemoglobin dan fungsi protein lainnya masih normal.

b. Tahap kedua, yaitu defisiensi besi tanpa anemia (Iron deficient erythropoietin atau iron limited erythropoiesis)

Pada tahap ini suplai besi tidak cukup menunjang eritropoiesis, kandungan hemoglobin pada retikulosit mulai menurun, namun masih belum menunjukkan gejala signifikan karena sebagian besar eritrosit yang bersirkulasi merupakan eritrosit yang diproduksi saat cadangan besi masih adekuat, sehingga total pengukuran hemoglobin masih dalam batas normal.

c. Tahap ketiga, yaitu anemia defisiensi besi (Iron deficiency anemia)

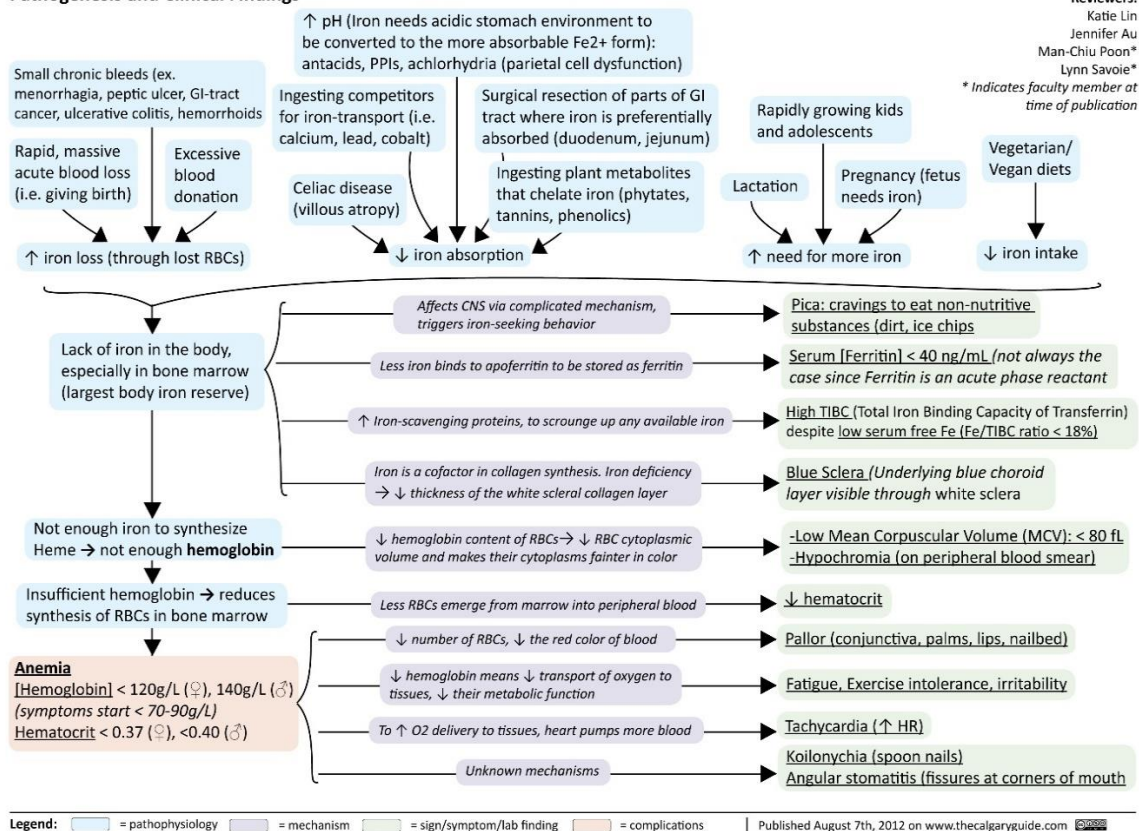
Pada tahap ini cadangan besi tidak cukup untuk menuju eritroid sumsum tulang, sehingga kadar Hb menurun. Sel darah merah juga mengalami perubahan jumlah, ukuran, pergerakan, maupun bentuk. Gejala yang

ditunjukkan semakin jelas baik tanda-tanda anemia yang tidak spesifik hingga anemia berat.

Tabel 1. Tahapan Kekurangan Besi (Fitriany & Saputri, 2018)

Hemoglobin	Tahap 1 Normal	Tahap 2 Sedikit Menurun	Tahap 3 Menurun Jelas (Mikrositik/Hipokromik)
Cadangan besi	< 100	0	0
Fe Serum	Normal	< 60	< 40
TIBC (<i>Total Iron-Binding Capacity</i>)	360 – 390	>390	>410
Saturasi Transferin	20 – 30	< 15	< 10
Feritin Serum	< 20	< 12	< 12
Sideroblas	40–60	< 10	< 10
FEP (<i>Free Erythrocyte Protoporphyrin</i>)	>30	>100	>200
MCV (<i>Mean Corpuscular Volume</i>)	Normal	Normal	Menurun

Iron Deficiency Anemia: Pathogenesis and Clinical Findings



4. Manifestasi Klinis

Tanda klinis anemia tidak spesifik (Maglaya, 2009). Pemeriksaan fisik berupa warna pucat terdapat pada konjungtiva, bibir bagian dalam, serta kuku dan telapak tangan. Gejala lainnya yaitu distress pernafasan, insomnia, kelelahan, dan tidak mampu konsentrasi.

Tanda-tanda anemia berupa: (1) 5L (Lesu, Lemah, Letih, Lelah, Lalai); (2) Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang; (3) Gejala lebih lanjut yaitu kelopak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak tangan menjadi pucat. Bila terdapat salah satu atau beberapa gejala tersebut kemungkinan menderita anemia.

5. Komplikasi Defisiensi Zat Besi

Zat besi dibutuhkan tubuh untuk membantu pengikatan oksigen guna membantu penyaluran zat-zat makanan yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jika tubuh kekurangan zat besi, maka fungsi maupun kinerja sel darah merah yang merupakan wadah zat besi dalam darah akan terganggu. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan fungsi intelektual, prestasi belajar, fungsi motorik dan peningkatan angka kesakitan (Maglaya, 2009).

Anemia defisiensi besi mempengaruhi perkembangan kognitif yang menyebabkan penurunan motorik, pendengaran dan penglihatan, sehingga terjadi penurunan kemampuan dan konsentrasi belajar (Lubis, 2008). Akibat lain yang ditimbulkan berupa penurunan aktivitas fisik dan daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko infeksi (Sutriyanto & Zainal, 2012).

6. Pemeriksaan Penunjang

Penegakan diagnosa anemia berdasarkan kadar nilai hemoglobin dan test biokimia lainnya yang direkomendasikan, yaitu jumlah hematokrit dan serum besi. (Maglaya, 2009). Selain itu, deteksi penurunan simpanan besi pada jaringan dapat dilakukan hitung darah lengkap dan pemeriksaan penurunan serum ferritin. Jika diprediksikan adanya perdarahan pada sistem gastrointestinal sebagai penyebab defisiensi besi, maka dapat dilakukan pemeriksaan feses (Fitriany & Saputri, 2018).

7. Penatalaksanaan Medis

Anemia defisiensi besi yang dinyatakan secara medis, pengobatannya membutuhkan suplemen zat besi. Adapun dosis yang digunakan disesuaikan dengan umur dan status kesehatan klien (Maglaya, 2009). Pada anak usia sekolah, dosis suplemen besi sebesar 1 mg/kgBB/hari, lama pemberian 2x/minggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun (Fitriany & Saputri, 2018).

Pengobatan lainnya dapat menggunakan kombinasi suplemen besi dan *folic acid*, diberikan 1x/minggu, dosis suplemen besi 45 mg dan 400 µg *folic acid*. Suplemen besi dikonsumsi diantara jam makan dan dibarengi dengan konsumsi air atau jus yang mengandung vitamin C. Minuman susu beserta produk turunannya, teh dan kopi dapat dikonsumsi 1 jam sebelum dan 2 jam sesudah mengonsumsi suplemen besi untuk mencegah penurunan absorpsi besi. Bagi anak dengan anemia kategori ringan ($Hb \geq 9$ g/dL) dapat melakukan pengulangan cek Hb atau hitung darah lengkap pada waktu 4 minggu setelah pengobatan. Bagi anak dengan anemia kategori sedang maupun berat ($Hb < 9$ g/dL) dapat dilakukan evaluasi hasil terapi setelah 7-10 hari meliputi peningkatan status kesehatan, retikulositosis, dan hemoglobin (Deepak Bansal, Nita Radhakrishnana, 2022).

D. Asuhan Keperawatan pada Agregat Anak Usia sekolah dengan Anemia

1. Pengkajian Individu dan Kelompok

Pengkajian merupakan proses pengumpulan, pengelompokan dan analisa data tentang kesehatan klien/ populasi. Data berupa kuantitatif dan kualitatif (Maglaya, 2009). Metode yang digunakan berupa observasi, wawancara, pengkajian fisik, maupun penyebaran angket/kuesioner guna mengetahui gambaran pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa, wali murid, maupun guru terkait anemia defisiensi besi.

a. Pengkajian Individu

Pengkajian yang dilakukan berdasarkan dimensi kesehatan yang ada pada individu, meliputi kesehatan fisik, mental, sosial, lingkungan, dan spiritual (Fertman & Allensworth, 2010). Pengkajian secara rinci, meliputi (Hendry, 2021):

- ii. Riwayat penyakit: Pengkajian riwayat penyakit digunakan untuk mengetahui perjalanan penyakit yang dialami guna mengetahui faktor penyebab dari penyakit tersebut. Pada kasus anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya ketidakcukupan nutrisi zat besi, ketidakseimbangan aktifitas fisik dengan pola istirahat, infeksi parasit misalnya kecacingan, maupun *personal hygiene* yang buruk.
- iii. Pemeriksaan fisik: Pemeriksaan fisik digunakan untuk mengetahui tanda dan gejala yang menunjukkan manifestasi klinis dari suatu penyakit meliputi gambaran jenis penyakit, jenis gejala penyakit maupun tingkat keparahan penyakit. Anemia defisiensi besi dapat dilihat dari pemeriksaan konjungtiva mata, bibir bagian dalam, kuku dan telapak tangan, maupun tanda-tanda vital. Selanjutnya dapat ditambah dengan pemeriksaan

penunjang meliputi kadar hemoglobin dalam darah dan hitung darah lengkap.

- iv. Riwayat pengobatan: Riwayat pengobatan perlu diketahui untuk menentukan terapi pengobatan yang efektif digunakan. Obat-obatan yang dapat menekan aktivitas sumsum tulang, menginduksi hemolisis, maupun mengganggu metabolisme folat, dapat menghambat efektifitas pengobatan anemia defisiensi besi.
- v. Riwayat penyakit keluarga: Anemia defisiensi besi bukan penyakit keturunan. Pengkajian riwayat penyakit keluarga ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya anggota keluarga lainnya yang menderita anemia defisiensi besi. Hal tersebut dapat menunjukkan pola perawatan kesehatan keluarga.
- vi. Penilaian nutrisi: Pengkajian nutrisi dapat dilakukan dengan menilai status gizi anak usia sekolah dan kebiasaan pola makan yang dapat menunjukkan kecukupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat.

b. Pengkajian Kelompok

Pengkajian kelompok anak usia sekolah didasarkan pada indikator kesehatan:

- i. Fisik, meliputi angka kesakitan, kelompok usia, status gizi, pemeriksaan gejala anemia, status kesehatan termasuk faktor risiko (*personal hygiene*, pola makan, dan pola istirahat), program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
- ii. Mental, meliputi angka kesakitan, kelompok usia, status kesehatan mental.
- iii. Sosial, meliputi tingkat ekonomi, status pendidikan, dukungan sosial, program layanan kesehatan di masyarakat dan norma sosial.
- iv. Lingkungan, berupa lingkungan fisik meliputi lingkungan internal (kondisi umum para siswa maupun guru) dan lingkungan eksternal (sistem pelaksanaan UKS (Unit Kesehatan Sekolah), program layanan kesehatan di sekolah, lingkungan kelas, dan lingkungan sekolah).
- v. Spiritual, berupa keyakinan terhadap sehat-sakit.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah identifikasi status kesehatan klien atau kebutuhan dan masalah berdasarkan analisa data/ informasi yang didapatkan (Maglaya, 2009). Diagnosis keperawatan yang dapat diangkat pada kasus anemia defisiensi besi pada anak usia sekolah, meliputi (PPNI, 2017):

- a. Perfusi Perifer Tidak Efektif (**D.0009**): Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh.
 - **Penyebab:** Penurunan konsentrasi hemoglobin.

- **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: pengisian kapiler >3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, dan turgor kulit menurun.
 - **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: parastesia; Objektif: indeks *ankle-brachial* <0,90
 - **Kondisi klinis terkait:** Anemia (defisiensi besi).
- b. Intoleransi Aktivitas (**D.0056**): Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
- **Penyebab:** Kelemahan.
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: mengeluh lelah; Objektif: frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat.
 - **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: dispnea saat/setelah aktifitas, merasa tidak nyaman setelah beraktivitas dan merasa lemah; Objektif: tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat dan tampak sianosis.
 - **Kondisi klinis terkait:** Anemia (defisiensi besi).
- c. Keletihan (**D.0057**): Penurunan kapasitas kerja fisik dan mental yang tidak pulih dengan istirahat.
- **Penyebab:** Kondisi fisiologis anemia (defisiensi besi).
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: merasa energi tidak pulih walaupun telah tidur dan kurang tenaga serta mengeluh lelah; Objektif: tidak mampu mempertahankan aktivitas rutin dan tampak lesu.
 - **Kondisi klinis terkait:** Anemia (defisiensi besi).
- d. Defisit Pengetahuan tentang (*spesifikkan*: anemia defisiensi besi) (**D.0111**): Ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu (anemia defisiensi besi).
- **Penyebab:** Kurang terpapar informasi (anemia defisiensi besi).
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: menanyakan masalah yang dihadapi; Objektif: menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran dan adanya persepsi yang keliru terhadap masalah (anemia defisiensi besi).
 - **Kondisi klinis terkait:** Kondisi klinis yang baru dihadapi oleh klien (anemia defisiensi besi); Penyakit akut (anemia defisiensi besi).
 - **Topik terkait:** gaya hidup sehat, manajemen penyakit akut (anemia defisiensi besi), manajemen proses penyakit (anemia defisiensi besi), perilaku sehat, maupun program diet.

- e. Risiko Infeksi (**D.0142**): Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik (mis. infeksi cacing/kecacingan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya anemia defisiensi besi).
- **Penyebab:** Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder (penurunan hemoglobin).
 - **Kondisi klinis terkait:** Terjadi imunosupresi; Terjadi leukositopenia.

Diagnosa keperawatan lainnya yang dapat digunakan untuk kelompok komunitas anak usia sekolah adalah (PPNI, 2017)(PPNI, 2017):

- a. Koping Komunitas Tidak Efektif (**D.0095**): Pola adaptasi aktivitas komunitas (kelompok anak usia sekolah) dan penyelesaian masalah (anemia defisiensi besi) yang tidak memuaskan untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- **Penyebab:** Ketidakadekuatan sumber daya untuk pemecahan masalah (anemia defisiensi besi); Ketidacukupan sumber daya masyarakat terkait dukungan sosial.
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: mengungkapkan ketidakberdayaan komunitas (kelompok anak usia sekolah); Objektif: insiden masalah masyarakat (anemia defisiensi besi) tinggi.
 - **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: mengungkapkan kerentanan komunitas (kelompok anak usia sekolah); Objektif: partisipasi masyarakat kurang dan tingkat penyakit (anemia defisiensi besi) meningkat.
 - **Kondisi klinis terkait:** Tingkat penyakit (anemia defisiensi besi) tinggi.
 - **Simpulan** diagnosis keperawatan coping komunitas tidak efektif pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi adalah ketidakmampuan komunitas/kelompok (anak usia sekolah) untuk berupaya beradaptasi menyelesaikan masalahnya (anemia defisiensi besi) akibat kurangnya dukungan sosial (keluarga/masyarakat/sekolah/pihak lainnya).
- b. Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (**D.0099**): Hambatan kemampuan (kelompok anak usia sekolah) dalam mengubah gaya hidup/perilaku untuk memperbaiki status kesehatan.
- **Penyebab:** Kurang terpapar informasi (anemia defisiensi besi); Ketidakadekuatan dukungan sosial; *Self efficacy* (kelompok anak usia sekolah) yang rendah.
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: menunjukkan penolakan terhadap perubahan status kesehatan dan upaya peningkatan status kesehatan yang minimal serta gagal

melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan (anemia defisiensi besi).

- **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: gagal mencapai pengendalian (status kesehatan) yang optimal.
 - **Kondisi klinis terkait:** Kondisi baru terdiagnosis penyakit (anemia defisiensi besi).
 - **Simpulan** diagnosis keperawatan perilaku kesehatan cenderung berisiko pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi adalah perilaku maladaptif (faktor penyebab anemia defisiensi besi meliputi pola makan, pola aktifitas dan istirahat, *personal hygiene*, dan sebagainya) yang dilakukan oleh populasi (anak usia sekolah), namun belum terjadi masalah kesehatan (anemia defisiensi besi).
- c. Defisit Kesehatan Komunitas (**D.0110**): Terdapat masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok (anak usia sekolah).
- **Penyebab:** Hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan; Keterbatasan sumber daya; Program (kesehatan) tidak memiliki anggaran yang cukup; Program (kesehatan) tidak atau kurang didukung komunitas (kelompok anak usia sekolah); Program (kesehatan) tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) komunitas (kelompok anak usia sekolah).
 - **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: terjadi masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) yang dialami komunitas (kelompok anak usia sekolah) dan terdapat faktor risiko fisiologis yang menyebabkan anggota komunitas (kelompok anak usia sekolah) menjalani perawatan.
 - **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: tidak tersedia program (kesehatan) untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas (kelompok anak usia sekolah), dan tidak tersedia program (kesehatan) untuk mencegah masalah, mengurangi masalah, maupun mengatasi masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) komunitas (kelompok anak usia sekolah).
 - **Simpulan** diagnosis keperawatan defisit kesehatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi adalah ada masalah resiko kesehatan dalam komunitas (anak usia sekolah) dan tidak ada program untuk meningkatkan kesehatan (upaya pencegahan maupun pengobatan anemia defisiensi besi) atau program yang ada tidak berjalan baik (sudah ada upaya pencegahan

maupun pengobatan anemia defisiensi besi namun tidak berjalan maksimal dan kurang efektif).

- d. **Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.0116):** Pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan.

- **Penyebab:** Kompleksitas sistem pelayanan kesehatan; Kompleksitas program perawatan/pengobatan (anemia defisiensi besi); Kurang terpapar informasi (anemia defisiensi besi); Ketidakefektifan pola perawatan kesehatan keluarga; Kekurangan dukungan sosial.
- **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: (kelompok anak usia sekolah) mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan (anemia defisiensi besi); Objektif: gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko maupun menerapkan program perawatan/pengobatan (anemia defisiensi besi) dalam kehidupan sehari-hari, dan aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan.
- **Kondisi klinis terkait:** Diagnosis baru (anemia defisiensi besi) yang mengharuskan perubahan gaya hidup.
- **Simpulan** diagnosis keperawatan manajemen kesehatan tidak efektif pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi adalah komunitas (kelompok anak usia sekolah) sudah mendapatkan program pengobatan, perawatan, atau terapi (anemia defisiensi besi), namun komunitas (kelompok anak usia sekolah) tidak dapat menjalankan program pengobatan, perawatan, atau terapi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

- e. **Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif (D.0117):** Ketidakmampuan (kelompok anak usia sekolah) mengidentifikasi, mengelola, dan/atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan.

- **Penyebab:** Hambatan kognitif (anemia defisiensi besi); Ketidakmampuan (kelompok anak usia sekolah atau keluarga) mengatasi masalah (anemia defisiensi besi); Ketidacukupan sumber daya (mis. keuangan, fasilitas).
- **Gejala dan Tanda Mayor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: (kelompok anak usia sekolah) kurang menunjukkan perilaku adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun pemahaman tentang perilaku sehat, dan tidak mampu menjalankan perilaku sehat.
- **Gejala dan Tanda Minor:** Subjektif: (tidak tersedia); Objektif: (kelompok anak usia sekolah) kurang menunjukkan minat untuk

meningkatkan perilaku sehat, dan tidak memiliki sistem pendukung (*support system*).

- **Simpulan** diagnosis keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi adalah adanya masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) namun kelompok/populasi (anak usia sekolah) kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan atau kurang kemauan untuk memelihara kesehatan.

3. Intervensi Keperawatan

a. *Self-Help Group*

Anak usia sekolah yang berumur 7-11 tahun berada pada stadium operasional konkret. Anak usia sekolah mampu melakukan berbagai tugas, memahami sesuatu seperti kenyataannya, mengkonservasi angka, memahami konsep melalui pengalaman sendiri dan lebih objektif (Monks et al., 2019). Berdasarkan stadium tersebut, anak cenderung memiliki gaya belajar *visual*, *visual reading*, *auditory*, maupun *kinaesthetic*. Anak belajar mengerjakan tugas yang diberikan baik dari apa yang dilihat, dibaca, didengar maupun yang membutuhkan gerakan.

Strategi intervensi keperawatan yang dapat diterapkan pada kelompok anak usia sekolah untuk bisa dilakukan secara mandiri (*self-help group*) adalah strategi intervensi profesional, meliputi:

- 1) Intervensi keperawatan berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (PPNI, 2019) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018).

a) Perfusi Perifer Tidak Efektif (**D.0009**)

- **Luaran:** Perfusi Perifer Meningkat (**L.02011**); Kriteria hasil: pengisian kapiler membaik, nadi perifer meningkat, akral membaik, warna kulit pucat menurun, turgor kulit membaik, parastesia menurun, dan indeks *ankle-brachial* membaik.
- **Intervensi:** (1) **Perawatan Sirkulasi (I.02079)**: periksa sirkulasi perifer meliputi nadi perifer, pengisian kapiler, warna, suhu, *ankle-brachial index*; lakukan hidrasi; dan informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan.

b) Intoleransi Aktivitas (**D.0056**)

- **Luaran:** Toleransi Aktivitas Meningkat (**L.05047**); Kriteria hasil: keluhan lelah menurun, frekuensi jantung membaik, dispnea saat/setelah aktivitas menurun, perasaan tidak nyaman setelah

beraktivitas menurun, perasaan lemah menurun, tekanan darah membaik, dan sianosis menurun.

- **Intervensi: (1) *Manajemen Energi (I.05178)*:** identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan; monitor kelelahan fisik dan emosional; monitor pola dan jam tidur; monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas; sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus meliputi cahaya, suara, kunjungan; berikan aktivitas distraksi yang menenangkan; anjurkan tirah baring; anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap; anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang; ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan; dan kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. (2) ***Terapi Aktivitas (I.05186)*:** identifikasi defisit tingkat aktivitas; identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu; identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan; identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas; monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas; fasilitasi fokus pada kemampuan, bukan defisit yang dialami; fasilitasi aktivitas motorik untuk merelaksasi otot; libatkan dalam permainan kelompok yang tidak kompetitif, terstruktur, dan aktif; libatkan keluarga dalam aktivitas, *jika perlu*; fasilitasi anak usia sekolah dan keluarga memantau kemajuannya sendiri untuk mencapai tujuan; jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari; berikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas; jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari, *jika perlu*; anjurkan cara melakukan aktivitas yang dipilih; anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi, *jika sesuai*; anjurkan keluarga untuk memberi penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas; serta kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas, *jika sesuai*.

c) Keletihan (**D.0057**)

- **Luaran:** Tingkat Keletihan Menurun (**L.05046**); Kriteria hasil: verbalisasi kepulihan energi meningkat, perasaan bertenaga meningkat, verbalisasi lelah menurun, kemampuan melakukan aktivitas rutin meningkat, dan lesu menurun.
- **Intervensi: (1) *Edukasi Aktivitas/Istirahat (I.12362)*:** identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi; sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat; jadwalkan

pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan; berikan kesempatan kepada anak usia sekolah dan keluarga untuk bertanya; jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik/olahraga secara rutin; anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, aktivitas bermain atau aktivitas lainnya; anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat; ajarkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat saat kelelahan; serta ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. (2) **Manajemen Energi (I.05178)**: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0056**).

d) Defisit Pengetahuan tentang (*spesifikkan*: anemia defisiensi besi) (**D.0111**)

- **Luaran**: Tingkat Pengetahuan Meningkat (**L.12111**); Kriteria hasil: pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, perilaku sesuai anjuran meningkat, dan persepsi yang keliru terhadap masalah menurun.
- **Intervensi**: (1) **Edukasi Kesehatan (I.12383)**: identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi; identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat; sediakan materi dan media pendidikan kesehatan; jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan; berikan kesempatan untuk bertanya; jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan; ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat; serta ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

e) Risiko Infeksi (**D.0142**) (misal: infeksi cacing/kecacingan)

- **Luaran**: Tingkat Infeksi Menurun (**L.14137**); Kriteria hasil: kebersihan tangan meningkat, kebersihan badan meningkat, dan kadar sel darah putih membaik.
- **Intervensi**: (1) **Pencegahan Infeksi (I.14539)**: monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik akibat adanya infeksi cacing/kecacingan; cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan anak usia sekolah dan lingkungannya; pertahankan teknik aseptik pada anak usia sekolah yang berisiko tinggi; jelaskan tanda dan gejala infeksi; ajarkan cara mencuci tangan dengan benar; anjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan cairan.

f) Koping Komunitas Tidak Efektif (**D.0095**)

- **Luaran**: Status Koping Komunitas (kelompok anak usia sekolah) Membaik (**L.09089**); Kriteria hasil: keberdayaan komunitas

(kelompok anak usia sekolah) meningkat, insiden masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) dalam komunitas (kelompok anak usia sekolah) menurun, kerentanan komunitas (kelompok anak usia sekolah) menurun, partisipasi masyarakat meningkat, dan tingkat kejadian penyakit (anemia defisiensi besi) menurun.

- **Intervensi:** (1) **Edukasi Kesehatan (I.12383)**: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0111**). (2) **Manajemen Lingkungan Komunitas (I.14515)**: lakukan skrining risiko gangguan kesehatan lingkungan; identifikasi faktor risiko yang diketahui; libatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan; promosikan kebijakan pemerintah untuk mengurangi risiko penyakit (anemia defisiensi besi); berikan pendidikan kesehatan untuk kelompok risiko (kelompok anak usia sekolah); informasikan layanan kesehatan ke anak usia sekolah, keluarga, kelompok berisiko dan masyarakat; kolaborasi dengan tim kesehatan lain dalam program kesehatan komunitas untuk menghadapi risiko yang diketahui; dan kolaborasi dalam pengembangan program aksi masyarakat (terkait pencegahan dan penanggulangan anemia defisiensi besi). (3) **Pengembangan Kesehatan Masyarakat (I.14548)**: identifikasi masalah atau isu kesehatan (anemia defisiensi besi) dan prioritasnya; identifikasi kekuatan dan *partner* dalam pengembangan kesehatan; identifikasi pemimpin/tokoh dalam masyarakat; libatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu dan masalah guna mengembangkan rencana kerja; libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi serta revisinya; pertahankan komunikasi yang terbuka dengan anggota masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat; kembangkan strategi dalam manajemen konflik; bangun komitmen antar anggota masyarakat.

g) Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (**D.0099**)

- **Luaran:** Perilaku Kesehatan Membaik (**L.12107**); Kriteria hasil: penerimaan terhadap perubahan status kesehatan meningkat, kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan (anemia defisiensi besi) meningkat, kemampuan peningkatan status kesehatan meningkat, dan pencapaian pengendalian kesehatan meningkat.
- **Intervensi:** (1) **Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)**: identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan;

berikan lingkungan yang mendukung kesehatan; orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan; anjurkan menggunakan air bersih; anjurkan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; anjurkan menggunakan jamban sehat; anjurkan makan sayur dan buah setiap hari; serta anjurkan melakukan aktivitas fisik setiap hari.

h) Defisit Kesehatan Komunitas (**D.0110**)

- **Luaran:** Status Kesehatan Komunitas Meningkat (**L.12109**); Kriteria hasil: angka morbiditas menurun, prevalensi penyakit (anemia defisiensi besi) menurun, ketersediaan program promosi kesehatan meningkat, ketersediaan program proteksi kesehatan meningkat, dan partisipasi dalam program kesehatan komunitas (kelompok anak usia sekolah) meningkat.
- **Intervensi:** (1) ***Pengembangan Kesehatan Masyarakat (I.14548)***: sama dengan intervensi (3) pada diagnosis keperawatan (**D.0095**). (2) ***Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)***: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0099**).

i) Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (**D.0116**)

- **Luaran:** Manajemen Kesehatan Meningkat (**L.12104**); Kriteria hasil: verbalisasi kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan (anemia defisiensi besi) menurun, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat, menerapkan program perawatan/pengobatan (anemia defisiensi besi) dalam kehidupan sehari-hari meningkat, dan aktivitas hidup sehari-hari efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan meningkat.
- **Intervensi:** (1) ***Dukungan Pengambilan Keputusan (I.09265)***: identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi (anemia defisiensi besi) yang memicu konflik; fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan; diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi; fasilitasi melihat situasi secara realistis; motivasi mengungkapkan tujuan perawatan (anemia defisiensi besi) yang diharapkan; fasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif; fasilitasi hubungan antara anak usia sekolah, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya; informasikan alternatif solusi (anemia defisiensi besi) secara jelas; berikan informasi (anemia defisiensi besi) yang diminta anak usia sekolah maupun keluarga; dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. (2) ***Dukungan Tanggung Jawab pada Diri Sendiri (I.09277)***:

identifikasi persepsi tentang masalah kesehatan (anemia defisiensi besi); monitor pelaksanaan tanggung jawab (kelompok anak usia sekolah); berikan kesempatan (kelompok anak usia sekolah) merasakan memiliki tanggung jawab; tingkatkan rasa tanggung jawab (kelompok anak usia sekolah) atas perilaku sendiri; berikan penguatan dan umpan balik positif jika (kelompok anak usia sekolah) melaksanakan tanggung jawab atau mengubah perilaku; dan diskusikan konsekuensi tidak melaksanakan tanggung jawab. (3) **Edukasi Kesehatan (I.12383)**: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0111**). (4) **Pelibatan Keluarga (I.14525)**: identifikasi kesiapan keluarga (kelompok anak usia sekolah) untuk terlibat dalam perawatan; ciptakan hubungan terapeutik anak usia sekolah dengan keluarga dalam perawatan; diskusikan cara perawatan di rumah; motivasi keluarga (kelompok anak usia sekolah) mengembangkan aspek positif rencana perawatan; fasilitasi keluarga (kelompok anak usia sekolah) membuat keputusan perawatan; jelaskan kondisi anak usia sekolah ke keluarga; anjurkan keluarga bersikap asertif dalam perawatan (anemia defisiensi besi); dan anjurkan keluarga terlibat dalam perawatan (anemia defisiensi besi).

j) **Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif (D.0117)**

- **Luaran:** Pemeliharaan Kesehatan Meningkat (**L.12106**); Kriteria hasil: (kelompok anak usia sekolah) menunjukkan perilaku adaptif meningkat, menunjukkan pemahaman perilaku sehat meningkat, kemampuan menjalankan perilaku sehat meningkat, menunjukkan minat meningkatkan perilaku sehat meningkat, dan memiliki sistem pendukung (*support system*) meningkat.
- **Intervensi:** (1) **Edukasi Kesehatan (I.12383)**: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0111**). (2) **Penentuan Tujuan Bersama (I.12464)**: identifikasi tujuan-tujuan yang akan dicapai; identifikasi cara mencapai tujuan secara konstruktif; nyatakan tujuan dengan kalimat positif dan jelas; prioritaskan aktivitas yang dapat membantu pencapaian tujuan; fasilitasi dalam mengidentifikasi hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan; tetapkan batas waktu yang realistis; tetapkan evaluasi secara periodik untuk menilai kemajuan sesuai tujuan; modifikasi rencana jika tujuan tidak tercapai; anjurkan mengenal masalah (anemia defisiensi besi) yang dialami; anjurkan mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan sendiri; anjurkan

mengidentifikasi nilai dan sistem kepercayaan saat menetapkan tujuan; serta anjurkan mengidentifikasi tujuan realistis dan dapat dicapai. (3) **Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)**: sama dengan intervensi (1) pada diagnosis keperawatan (**D.0099**).

2) Aplikasi demonstrasi keterampilan dasar.

Strategi ini digunakan sebagai strategi modeling, sehingga kelompok anak usia sekolah mampu mempelajari dan mengadopsi perilaku sehat yang diajarkan oleh perawat kesehatan komunitas. Keterampilan dasar yang didemonstrasikan berupa pengenalan gejala anemia, pengenalan tumpeng gizi seimbang, pengenalan komponen kebersihan diri, perilaku cuci tangan maupun sikat gigi yang benar, latihan penyusunan jadwal harian, latihan penyusunan menu makanan, dan latihan pengaturan jadwal makan maupun komposisi makanan.

Perawat kesehatan komunitas dapat menggunakan metode pengajaran berupa pendidikan kesehatan *multi method approaches*, meliputi perkenalan (*icebreaking*), alat dengar (*audio*), alat peraga (*audiovisual*), kerjasama pembelajaran dan kelompok kerja, diskusi, permainan edukasi, percobaan dan demonstrasi, darmawisata, ceramah, musik, edukasi sebaya, wayang/ boneka, berganti peran (*role play*), simulasi, bercerita, permainan kata/ teka-teki dan *puzzle*.

b. Support Group

Strategi intervensi keperawatan proses kelompok yang melibatkan orang lain dalam memberikan dukungan pada kelompok anak usia sekolah (*support group*) yaitu kelompok sebaya (*peer group*) dengan melibatkan peran kader kesehatan sekolah sebagai bentuk aplikasi strategi *empowerment*. Kader kesehatan sekolah berperan sebagai pendidik sebaya yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada teman sebaya di lingkungan sekolah, disamping tugas dan kewajiban lainnya sesuai dengan program kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Proses kegiatan pendidikan kesehatan dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil sehingga teman sebaya dapat mudah terpapar dan memahami informasi kesehatan yang disampaikan oleh kader kesehatan sekolah. Selain itu, peran guru, orang tua dan masyarakat juga diperlukan sebagai bagian dari kelompok pendukung (*support group*).

c. Kemitraan

Pendidikan kesehatan juga melibatkan puskesmas dan pihak sekolah dalam bentuk kemitraan (*partnership*) untuk menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan anak usia sekolah maupun praktik pendidikan kesehatan yang direncanakan, serta keterlibatan keluarga maupun masyarakat guna

mendukung promosi kesehatan maupun pemberian dukungan yang menunjang kesehatan anak usia sekolah. Adapun indikator keberhasilan pendidikan kesehatan di keluarga dapat dievaluasi melalui tingkat kemandirian keluarga berdasarkan Kepmenkes RI No.279/MENKES/SK/2006 tentang pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di puskesmas (Depkes RI, 2010), yaitu:

- 1) Keluarga mandiri tingkat pertama (KM-I): (a) menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat; (b) menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.
- 2) Keluarga mandiri tingkat dua (KM-II): (a) memenuhi KM-I; (b) tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar; (c) melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan.
- 3) Keluarga mandiri tingkat tiga (KM-III): (a) memenuhi KM-II; (b) memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif; (c) melakukan tindakan pencegahan secara aktif.
- 4) Keluarga mandiri tingkat empat (KM-IV): (a) memenuhi KM-III; (b) melaksanakan tindakan promotif secara aktif.

Adapun strata pelaksanaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat SD/MI dalam mengembangkan pendidikan kesehatan, meliputi:

- 1) Minimal: (a) mata pelajaran Penjasorkes (Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan) dilaksanakan secara kurikuler atau terintegrasi saja; (b) guru membuat rencana pembelajaran pendidikan kesehatan; (c) ada buku pegangan guru dan bacaan tentang pendidikan kesehatan.
- 2) Standar: (a) memenuhi strata minimal; (b) memiliki guru mata pelajaran Penjasorkes; (c) Penjasorkes juga dilaksanakan secara ekstrakurikuler.
- 3) Optimal: (a) memenuhi strata standar; (b) Penjasorkes terintegrasi dalam mata pelajaran lain; (c) memiliki alat peraga pendidikan kesehatan; (d) memiliki media pendidikan kesehatan (poster dan lain-lain).
- 4) Paripurna: (a) memenuhi strata optimal; (b) memiliki guru pembina UKS; (c) danya program kemitraan pendidikan kesehatan dengan instansi terkait (Puskesmas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan lain-lain).

4. Implementasi Keperawatan

Fase implementasi dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat bersama klien (anak usia sekolah) ataupun anggota tim lainnya (keluarga, guru, teman sebaya, dan pihak lainnya). Proses ini membutuhkan kemampuan untuk meningkatkan potensi kemandirian terhadap kesejahteraan, pencegahan, manajemen maupun kontrol masalah kesehatan (Maglaya, 2009).

Implementasi asuhan keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah dengan anemia defisiensi besi berdasarkan Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan (PPNI, 2021), meliputi:

- a. **Perawatan Sirkulasi (I.02079)**: pemantauan *capillary refill time* (CRT); pemantauan *mean artery pressure* (MAP); pemantauan tanda dan gejala perdarahan; pemantauan tanda vital; pengaturan posisi trendelenburg; pemantauan saturasi oksigen; pemberian oksigen dengan nasal kanul.
- b. **Manajemen Energi (I.05178)**: pengaturan posisi semi-fowler; pemantauan tanda vital; pengaturan posisi supine; dukungan tidur; pemantauan kelelahan fisik dan mental; pemberian tirah baring; dukungan pengambilan keputusan; promosi koping.
- c. **Terapi Aktivitas (I.05186)**: pengaturan posisi semi-fowler; pemantauan tanda vital; pengaturan posisi supine; pemantauan kelelahan fisik dan mental; pemberian tirah baring.
- d. **Edukasi Aktivitas/Istirahat (I.12362)**: dukungan tidur; dukungan pengambilan keputusan; pemantauan kelelahan fisik dan mental; pemberian tirah baring; promosi koping.
- e. **Edukasi Kesehatan (I.12383)**: dukungan pengambilan keputusan; edukasi keterampilan koping; edukasi keterampilan pencegahan kekambuhan; pemberian terapi perilaku; pemberian terapi suportif 1; pemberian terapi suportif 2; pemberian terapi suportif 3; pemberian terapi suportif 4; promosi sistem pendukung; bimbingan antisipatif; bimbingan sistem kesehatan; edukasi keluarga; edukasi kesehatan; manajemen kasus; dukungan keluarga merencanakan perawatan; edukasi komunikasi efektif; promosi dukungan sosial; promosi komunikasi efektif.
- f. **Pencegahan Infeksi (I.14539)**: pemantauan tanda vital; pengambilan spesimen; identifikasi risiko masalah kesehatan; kebersihan tangan dengan handrub; kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir; pencegahan infeksi.
- g. **Manajemen Lingkungan Komunitas (I.14515)**: edukasi keterampilan koping.
- h. **Pengembangan Kesehatan Masyarakat (I.14548)**: edukasi keterampilan koping.
- i. **Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)**: dukungan kelompok; dukungan pengambilan keputusan; pemberian terapi kelompok; pemberian terapi perilaku; promosi koping.
- j. **Dukungan Pengambilan Keputusan (I.09265)**: stimulasi kognitif; diskusi kelompok terarah; dukungan pengambilan keputusan; edukasi keterampilan pencegahan kekambuhan; pelibatan keluarga dalam program perawatan; pemberian terapi suportif 1; pemberian terapi suportif 2; pemberian terapi suportif 3; pemberian terapi suportif 4; promosi sistem pendukung; bimbingan

antisipatif; bimbingan sistem kesehatan; edukasi kesehatan; manajemen kasus; dukungan keluarga merencanakan perawatan.

- k. ***Dukungan Tanggung Jawab pada Diri Sendiri (I.09277)***: diskusi kelompok terarah; dukungan pengambilan keputusan; edukasi keterampilan pencegahan kekambuhan; pelibatan keluarga dalam program perawatan; pemberian terapi suportif 1; pemberian terapi suportif 2; pemberian terapi suportif 3; pemberian terapi suportif 4; promosi sistem pendukung; bimbingan antisipatif; bimbingan sistem kesehatan; edukasi kesehatan; manajemen kasus; dukungan keluarga merencanakan perawatan.
- l. ***Pelibatan Keluarga (I.14525)***: diskusi kelompok terarah; dukungan pengambilan keputusan; edukasi keterampilan pencegahan kekambuhan; pelibatan keluarga dalam program perawatan; pemberian terapi suportif 1; pemberian terapi suportif 2; pemberian terapi suportif 3; pemberian terapi suportif 4; promosi sistem pendukung; bimbingan antisipatif; bimbingan sistem kesehatan; edukasi kesehatan; manajemen kasus; dukungan keluarga merencanakan perawatan.
- m. ***Penentuan Tujuan Bersama (I.12464)***: pemberian terapi perilaku; edukasi kesehatan; edukasi komunikasi efektif; promosi dukungan sosial; promosi komunikasi efektif.

5. Evaluasi Keperawatan

Fase evaluasi meliputi evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses merupakan kesimpulan sementara dari hasil implementasi yang dilakukan guna penentuan modifikasi atau intervensi lanjutan. Evaluasi hasil merupakan kesimpulan dari proses terminasi, lanjutan maupun perubahan selama intervensi. Fokus evaluasi pada individu meliputi: kualitas hidup, status fungsional, kenyamanan, komplikasi, dan akibat dari pendidikan kesehatan. Fokus evaluasi pada suatu program kegiatan meliputi input, proses, dan output (Maglaya, 2009).

*- "Hiduplah seolah engkau mati besok" -
Belajarliah seolah engkau hidup selamanya."*

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Lansia. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสต์เทิร์นเอเชีย*, 4(1), 88–100.
- Anderson, E. T., & McFarlane, J. (2014). Community as partner: Theory and practice in nursing. In *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*. <https://doi.org/10.1097/00000446-199610000-00015>
- Ariani, S. (2016). Stop Gagal Ginjal dan Gangguan-Gangguan Ginjal Lainnya: Seputar Ginjal dan Rogam Jenis Lainnya. In *Jogjakarta: Wirogunan*.
- CDC. (2015). *What is prevention?*
- Deepak Bansal, Nita Radhakrishnana, A. P. (2022). *STANDARD TREATMENT GUIDELINES 2022 Iron Deficiency Anemia*.
- Depkes RI. (2010). *Pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas*.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Anemia Defisiensi Besi Pada Anak. *Kementerian Kesehatan RI*, 9(3), 2022.
- Djokic, D., Drakulovic, M. B., Radojicic, Z., Crncevic Radovic, L., Rakic, L., Kocic, S., & Davidovic, G. (2010). Risk factors associated with anemia among Serbian school-age children 7-14 years old: Results of the first national health survey. *Hippokratia*, 14(4), 252–260.
- Edelman, Carole Lium; Mandle, Carol Lynn; and Kazer, M. W. (2006). *Health Promotion Throughout the Lifespan* (6th ed.). Mosby YearBook, Inc.
- Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (2010). Health promotion program. In *Journal of the Tennessee Medical Association* (Vol. 75, Issue 9).
- Fitriany, J., & Saputri, A. I. (2018). Anemia Defisiensi Besi. *Jurnal. Kesehatan Masyarakat*, 4(1202005126), 1–30.
- Hendry, Z. (2021). *Askep Anemia Pendekatan SDKI SLKI dan Konsep Medik dan Asuhan Keperawatan (Askep) Anemia Definisi*.
- Hockenberry, Marilyn J.; Rodgers, Cheryl C.; Wilson, D. M. (2017). *Wong's Essentials of Pediatric Nursing* (Tenth). Elseiver, Inc.
- Hutagaol, E. V. (2017). Peningkatan Kualitas Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisa Melalui Psychological Intervention di Unit Hemodialisa RS Royal Prima Medan Tahun 2016. *Jurnal Jumantik*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/13507486.2015.1047603>
- IDF. (2019). International Diabetes Federation. In *The Lancet* (Vol. 266, Issue 6881). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(55\)92135-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(55)92135-8)
- Indrasari, D. N. (2015). Perbedaan Kadar Ureum dan Kreatinin Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Berdasarkan Lama Menjalani Terapi Hemodialisa di RS PKU

- Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*.
- Kaneto, H. (2015). Pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. In *Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine* (Vol. 73, Issue 12, pp. 2003–2007). <https://doi.org/10.1093/med/9780199235292.003.1336>
- Kemendes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia 2019. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kemendes Kesehatan RI. (2020). Infodatin tetap produktif, cegah, dan atasi Diabetes Melitus 2020. In *Pusat Data dan Informasi Kemendes Kesehatan RI* (pp. 1–10).
- Kemendes Kesehatan RI. (2017). *Pencegahan Diabetes Mellitus*.
- Lee, P. G., & Halter, J. B. (2017). The pathophysiology of hyperglycemia in older adults: Clinical considerations. *Diabetes Care*, 40(4), 444–452. <https://doi.org/10.2337/dc16-1732>
- Lubis, B. (2008). Pencegahan Anemia Defisiensi Besi Sejak Bayi Sebagai Salah Satu Upaya Optimalisasi Fungsi Kognitif Anak Pada Usia Sekolah. ... *Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*
- Maglaya, A. S. (2009). *Nursing Practice in the Community* (Fifth). Argonauta Corporation.
- Mansjoer, A. (2014). Kapita Selekta Kedokteran Edisi IV. In *Jakarta: Media Aesculapius*.
- Mary, B. (2008). Klien Gangguan Hati. Seri Asuhan Keperawatan. In *Jakarta : EGC*.
- McClinchy, J. (2018). Dietary management of older people with diabetes. *British Journal of Community Nursing*, 23(5), 248–251. <https://doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.5.248>
- McLean, E., Cogswell, M., Egli, I., Wojdyla, D., & De Benoist, B. (2009). Worldwide prevalence of anaemia, WHO Vitamin and Mineral Nutrition Information System, 1993–2005. *Public Health Nutrition*, 12(4), 444–454. <https://doi.org/10.1017/S1368980008002401>
- Miller, J., & Rosso, D. (2009). Investasi untuk Kesehatan dan Gizi Sekolah di Indonesia. *Basic Education Capacity-Trust Fund*, 1–35.
- Monks, F. ., Knoers, A. M. ., & Hadinoto, S. R. (2019). *Psikologi perkembangan: pengantar dalam berbagai bagiannya* (18th ed.). Gajah Mada University Press.
- Najikhah, U., & Warsono, W. (2020). Penurunan Rasa Haus Pada Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) Dengan Berkumur Air Matang. *Ners Muda*, 1(2), 108. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5655>
- Nakata, P. T., Koltermann, L. I., Vargas, K. R. de, Moreira, P. W., Duarte, Ê. R. M., & Rosset-Cruz, I. (2013). Classification of family risk in a Family Health Center. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 21(5), 1088–1095. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692013000500011>

- Padila. (2018). Buku Ajar Keperawatan Keluarga. In *Yogyakarta: Nuha Medika*.
- Paolisso, G. (2010). Pathophysiology of diabetes in elderly people. *Acta Biomedica*, 81(SUPPL. 1), 47–53.
- Papalia, D. E. (2004). *Human Development* (9th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- PERKENI. (2020). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2015. (2015). PB PERKENI. *Global Initiative for Asthma*, 46. www.ginasthma.org.
- PERKENI, et all. (2019). Pengelolaan Dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia. *Perkeni*, 133.
- Permanasari, N. (2012). *Asuhan Keperawatan Pada Ny. M Dengan Chronic Kidney Disease di Ruang Hemodialisa RSUD DR. Moewardi Surakarta*.
- PERNEFRI. (2018). 11th report Of Indonesian renal registry 2018. *Indonesian Renal Registry (IRR)*, 14–15.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Price A Sylvia dan Wilson, L. M. (2012). Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6. In *Jakarta: EGC*.
- Priscilla LeMone, Karen M. Burke, G. B. (2011). Medical-Surgical Nursing: Critical Thinking in Patient Care 5th Edition. In *New Jersey: Pearson Prentice Hall*.
- Priscilla LeMone, Karen M. Burke, G. B. (2016). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. In *Jakarta : EGC*.
- Putri, N. M., Briawan, D., & Baliwati, Y. F. (2021). Faktor Risiko Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Temanggung. *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2021.008.01.4>
- Rani, J., & Bandrapalli, E. (2017). Study of Prevalence of Anaemia in School Children and Factors Associated with It. *International Journal of Contemporary Medical Research*, 4(9), 2454–7379.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar. *Kementrian Kesehatan RI*, 1–582.
- Safitri, A. Z., Fajariyah, R. N., & Astutik, E. (2021). Risk Factors of Diabetes Mellitus in Urban Communities in Indonesia (IFLS 5). *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.20473/jbe.v9i22021.184-191>
- Sirajuddin, S., & Masni, M. (2015). Kejadian Anemia pada Siswa Sekolah Dasar. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(3), 264.

- <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i3.574>
- Smeltzer, S. C. dan B. G. B. (2015). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddart. In *Jakarta: EGC*.
- Suastika, et al. (2012). Age is an Important Risk Factor for Type 2 Diabetes Mellitus and Cardiovascular Diseases. In *Glucose Tolerance*.
<https://doi.org/10.5772/52397>
- Susanti, K. dan. (2019). Keperawatan Medikal Bedah 1. In *Yogyakarta : Pustaka Baru*.
- Sutriyanto, E., & Zainal, E. (2012). *Jangan Biarkan Anak Kekurangan Zat Besi*. University of Calgary. (2012). *Iron Deficiency Anemia | Calgary Guide*.
- Webber, S. (2021). International Diabetes Federation. In *Diabetes Research and Clinical Practice* (Vol. 102, Issue 2).
<https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.10.013>
- Welfare, M. of health and family. (2013). Guidelines for Control of Iron Deficiency Anaemia. *National Rural Health Mission*, 54.
- World Health Organization. (2018). WHO - The top 10 causes of death. In *24 Maggio* (pp. 1–7). <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT DEWASA DENGAN GAGAL GINJAL KRONIS (GGK)



Asuhan Keperawatan Komunitas pada Agregat Dewasa dengan Gagal Ginjal Kronis (GGK)

A. Tujuan Penulisan

Setelah membaca topik asuhan keperawatan pada agregat dewasa dengan gagal ginjal kronis (GGK) maka pembaca mampu memahami tentang konsep penyakit GGK, proses asuhan keperawatan komunitas pada dewasa dengan GGK serta berbagai inovasi yang mendukung perawat komunitas dalam penatalaksanaannya. Asuhan keperawatan komunitas ini disusun berdasarkan penulisan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

B. Fenomena Penyakit Gagal Ginjal Kronis (GGK)

Arus globalisasi yang semakin meningkat membawa perubahan gaya dan perilaku hidup masyarakat, situasi lingkungan salah satunya pola penyakit tidak menular. Prevalensi penyakit tidak menular semakin meningkat diantaranya penyakit ginjal kronis, kanker, stroke, diabetes mellitus dan hipertensi (Risikesdas, 2018). Menurut *World Health Organization* (WHO) secara global, lebih dari 500 juta orang dan yang harus menjalani hidup dengan bergantung pada cuci darah (hemodialisis) 1,5 juta orang, memperlihatkan yang menderita gagal ginjal baik akut maupun kronik mencapai 50% sedangkan yang diketahui dan mendapatkan pengobatan hanya 25% dan 12,5% yang terobati dengan baik (Indrasari, 2015).

Prevalensi orang dengan gagal ginjal kronis di Indonesia pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu dari 0,2% menjadi 0,38% sehingga penderita gagal ginjal kronis setiap tahunnya semakin meningkat. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, presentase kejadian penyakit gagal ginjal kronis sebesar 3,4% dari total penduduk di Jawa Tengah. Prevalensi gagal ginjal pada laki-laki (0,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (0,2%). Berdasarkan karakteristik umur prevalensi tertinggi pada kategori usia diatas 75 tahun (0,6%) sebab pada umur 35 tahun keatas mulai terjadi peningkatan (Risikesdas, 2018). Kemudian pada tahun 2017 ditemukan kasus baru penderita penyakit gagal ginjal kronis sebesar 27.637 orang. Penyakit ginjal kronik menjadi penyebab ke-18 kematian didunia pada tahun 2010 (Kemenkes RI, 2019). Berdasarkan data *Indonesian Renal Registry* jumlah pasien aktif yang menjalani dialysis pada tahun 2015 yaitu sebesar 30.554 pasien (PERNEFRI, 2018).

C. Konsep Penyakit Gagal Ginjal Kronis (GGK)

1. Definisi Gagal Ginjal Kronik

Gagal Ginjal Kronik atau *Chronic Kidney Disease* (CKD) saat ini merupakan masalah kesehatan yang penting mengingat selain insidens dan pravelensinya yang

semakin meningkat, pengobatan pengganti ginjal yang harus di jalani oleh penderita gagal ginjal merupakan pengobatan yang sangat mahal. Dialisa adalah suatu tindakan terapi pada perawatan penderita gagal ginjal terminal. Tindakan ini sering juga disebut sebagai terapi pengganti karena berfungsi menggantikan sebagian fungsi ginjal. Terapi pengganti yang sering di lakukan adalah hemodialisis dan peritonealialisa. Diantara kedua jenis tersebut, yang menjadi pilihan utama dan metode perawatan yang umum untuk penderita gagal ginjal adalah hemodialisis (Permanasari, 2012). Gagal ginjal adalah gangguan fungsi renal yang irreversible dan progresif, dimana fungsi ginjal penurunan dalam mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga terjadi uremia. Gagal ginjal biasanya akibat akhir dari kehilangan fungsi ginjal lanjut secara bertahap. Penyakit ini umumnya baru bisa terdeteksi melalui tes urine darah. Gejalanya hingga mencapai stadium lanjut (Ariani, 2016).

Gagal ginjal terjadi saat ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolik tubuh atau melakukan fungsi regulernya. Bahan yang biasanya dieliminasi di urin menumpuk dalam cairan tubuh sebab gangguan pada eksresi renal menimbulkan gangguan endrokin metabolik, cairan, elektrolit serta asam basa. Gagal ginjal adalah kondisi penurunan fungsi ginjal sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan filtrasi sisa metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan elektrolit misalnya sodium dan kalium di dalam darah atau urin. Perkembangan penyakit ini secara perlahan sampai semakin memburuknya fungsi ginjal hingga fungsinya menghilang (Hutagaol, 2017).

2. Etiologi Gagal Ginjal Kronik

Penyebab dari penyakit gagal ginjal kronik menurut (Price A Sylvia dan Wilson, 2012) yaitu sebagai berikut:

Klasifikasi Penyakit	Penyakit
Penyakit Infeksi Tubulointerstitial	Pielonefritis kronis atau refluks nefropati
Penyakit Peradangan	Glomerulonefritis
Penyakit Vaskuler Hipertensif	Nefrosklerosis benigna, nefrosklerosis maligna, stenosis arteria renalis
Gangguan Jaringan Ikat	Lupus eritematosus sistemik, poliarteritis nodosa
Gangguan konginetal dan herediter	Penyakit ginjal polikistik, asidosis tubulus ginjal
Penyakit metabolik	Diabetes militus, gout, hiperparatiroidisme
Nefropati obstruktif	Penyalahgunaan analgesik, nefropati timah

3. Patofisiologi Gagal Ginjal Kronik

Ketika terjadi kegagalan ginjal sebagian nefron (tubulus dan glomerulus) diduga utuh sedangkan yang lain rusak (hipotesa nefron utuh). Nefron-nefron yang utuh hipertrofi dan memproduksi volume filtrasi meningkat disertai reabsorpsi walaupun dalam kondisi penurunan GFR/daya saring. Metode adaptif ini memungkinkan ginjal berfungsi sampai $\frac{3}{4}$ dari nefron–nefron rusak. Beban yang harus dilarut menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang bisa direabsorpsi menyebabkan diuresis osmotik disertai poliuri dan haus. Kemudian karena bertambah banyak jumlah nefron rusak timbul oliguri disertai retensi produk sisa. Titik timbulnya gejala pada pasien menjadi lebih jelas dan muncul gejala khas kegagalan ginjal jika fungsi ginjal telah hilang kira-kira 80% - 90%. Saat tingkat ini fungsi renal yang demikian nilai kreatinin clearance turun sampai 15 ml/menit atau lebih rendah. Fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein (normalnya diekskresikan ke dalam urin) tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah, akan semakin berat (Priscilla LeMone, Karen M. Burke, 2011).

a. Gangguan Klirens Ginjal

Penurunan jumlah fungsi glomeruli menimbulkan banyak masalah pada ginjal membuat klirens substansi darah menurun dibersihkan oleh ginjal. Deteksi penurunan laju filtrasi glomerulus (GFR) dengan memperoleh urin 24-jam sebagai bentuk pemeriksaan klirens kreatinin. Menurut filtrasi glomerulus (akibat tidak berfungsinya glomeruli) klirens kreatinin akan turun dan kadar kreatinin meningkat. Selain itu, kadar nitrogen urea darah (BUN) biasanya meningkat. Kreatinin serum merupakan indikator paling sensitif dari fungsi karena substansi ini diproduksi secara konstan oleh tubuh. BUN tidak hanya dipengaruhi oleh penyakit renal, tetapi juga oleh masukan protein dalam diet, katabolisme (jaringan dan luka RBC), dan medikasi seperti steroid.

b. Retensi Cairan dan Urem

Ginjal juga tidak mampu untuk mengkonsentrasi atau mengencerkan urin secara normal pada penyakit ginjal tahap akhir, respon ginjal yang sesuai terhadap perubahan masukan cairan dan elektrolit sehari-hari, tidak terjadi. Pasien sering menahan natrium dan cairan, meningkatkan resiko terjadinya edema, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Hipertensi juga dapat terjadi akibat aktivasi aksis rennin angiotensin dan kerja sama keduanya meningkatkan sekresi aldosteron. Pasien lain mempunyai kecenderungan untuk kehilangan garam, mencetuskan resiko hipotensi dan hipovolemia. Episode muntah dan diare menyebabkan penipisan air dan natrium, yang semakin memperburuk status uremik.

c. Asidosis

Semakin berkembangnya penyakit renal maka akan terjadi asidosis metabolic seiring dengan ketidakmampuan ginjal mengekskresikan muatan asam (H^+) yang berlebihan. Penurunan sekresi asam terutama akibat ketidakmampuan tubulus ginjal untuk menyekresi ammonia (NH_3^-) dan mengabsorpsi natrium bikarbonat (HCO_3). Penurunan ekskresi fosfat dan asam organik lain juga terjadi

d. Anemia

Sebagai akibat dari produksi eritropoetin yang tidak adekuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi dan kecenderungan untuk mengalami perdarahan akibat status uremik pasien, terutama dari saluran gastrointestinal. Pada gagal ginjal, produksi eritropoetin menurun dan anemia berat terjadi, disertai kelelahan, angina dan sesak napas.

e. Ketidakseimbangan Kalsium dan Fosfat

Abnormalitas utama gagal ginjal kronis yakni gangguan metabolisme kalsium dan fosfat. Kadar serum kalsium dan fosfat tubuh berhubungan saling timbal balik, jika salah satunya meningkat, maka lainnya menurun. Filtrasi yang menurun melalui glomerulus ginjal, meningkatkan kadar serum fosfat dan sebaliknya penurunan kadar kalsium serum menyebabkan sekresi parathormon dari kelenjar paratiroid. Namun, pada gagal ginjal tubuh tak merespon secara normal terhadap peningkatan sekresi parathormon dan mengakibatkan perubahan pada tulang dan peyakit tulang. Selain itu juga metabolit aktif vitamin D (1,25-dehidrokolekalsiferol) yang secara normal dibuat di ginjal menurun.

f. Penyakit Tulang Uremik

Disebut Osteodistrofi renal, terjadi dari perubahan kompleks kalsium, fosfat dan keseimbangan parathormon.

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinik gagal ginjal kronik berat disertai sindrom azotemia sangat kompleks, yakni kelainan berbagai organ seperti: kelainan hemopoeisis, saluran cerna, mata, kulit, selaput serosa, neuropsikiatri dan kardiovaskular (Smeltzer, 2015).

a. Kelainan hemopoeisis

Anemia normokrom normositer dan normositer (MCV 78-94 CU), sering ditemukan pada pasien gagal ginjal kronik. Anemia yang terjadi sangat bervariasi bila ureum darah lebih dari 100 mg% atau bersihan kreatinin kurang dari 25 ml per menit.

b. Kelainan saluran cerna

Keluhan utama sebagian pasien gagal ginjal kronik yaitu mual dan muntah khususnya pada stadium terminal tetapi patogenesisnya belum jelas,

diduga berkaitan dengan dekompresi oleh flora usus sehingga amonia terbentuk. Amonia membuat rangsangan atau iritasi mukosa lambung dan usus halus serta hilang atau mereda sesudah pembatasan diet protein dan antibiotika.

c. Kelainan mata

Pada sebagian kecil pasien gagal ginjal kronik dijumpai visus hilang (azotemia amaurosis) setelah beberapa hari memperoleh pengobatan gagal ginjal kronik yang adekuat, seperti hemodialisis. Kelainan saraf mata menimbulkan gejala nistagmus, miosis dan pupil asimetris. Kelainan retina (retinopati) disebabkan hipertensi maupun anemia yang sering dijumpai pada pasien gagal ginjal kronik. Penimbunan atau deposit garam kalsium pada *conjunctiva* menyebabkan gejala *red eye syndrome* akibat iritasi dan hipervaskularisasi. Keratopati mungkin juga dijumpai pada beberapa pasien gagal ginjal kronik akibat penyulit hiperparatiroidisme sekunder atau tersier.

d. Kelainan selaput serosa

Kelainan selaput serosa seperti perikarditis dan pleuritis sering dijumpai pada gagal ginjal kronik khususnya pada stadium terminal serta termasuk salah satu indikasi mutlak untuk segera dilakukan dialisis.

e. Kelainan kulit

Gatal yang mengganggu sering dikaitkan dengan hiperparatiroidisme sekunder yang akan segera hilang sesudah tindakan paratiroidektomi. Kulit biasanya bersisik dan kering, tidak jarang dijumpai timbunan kristal urea pada kulit muka (*urea frost*)

f. Kelainan neuropsikiatri

Beberapa kelainan mental ringan yang sering dijumpai pada pasien GJK seperti emosi labil, dilusi, insomnia, dan depresi sering dijumpai pada pasien gagal ginjal kronik. Kelainan mental berat seperti konfusi, dilusi, dan tidak jarang disertai gejala psikosis juga. Sering dijumpai pada pasien dengan atau tanpa hemodialisis, dan tergantung dari dasar kepribadiannya (personalitas).

g. Kelainan kardiovaskular

Patogenesis gagal jantung kongestif (GJK) pada gagal ginjal kronik sangat kompleks. Beberapa faktor seperti anemia, hipertensi, aterosklerosis, kalsifikasi sistem vaskular, sering dijumpai pada pasien gagal ginjal kronik terutama pada stadium terminal dan dapat menyebabkan kegagalan faal jantung

Gejala CKD menurut (Mansjoer, 2014) antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Umum	: Fatig, malaise, gagal tumbuh
Kulit	: Pucat, mudah lecet, rapuh, leukonikia

Kepala dan	: Fetor uremik, lidah kering dan berselaput
Leher	: Fundus hipertensif, mata merah
Mata	: Hipertensi, kelebihan cairan, gagal jantung,
Kardiovaskuler	perikarditis uremik.
Pernafasan	: Hiperventilasi asidosis, edema paru, efusi pleura
Gastrointestinal	: Anoreksia, mual, gastritis, ulkus peptikum, kolitis uremik, diare karena antibiotik.
Kemih	: Nokturia, poliuria, haus, proteinuria
Reproduksi	: Penurunan libido, amenore
Saraf	: Letargi, tremor, mengantuk, kebingungan, kejang,
Tulang	koma
Sendi	: Defisiensi vitamin D
Hematologi	: Gout, kalsifikasi ekstra tulang : Anemia, defisiensi imun, mudah mengalami perdarahan

5. Komplikasi Gagal Ginjal Kronik

Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit dimana organ ginjal mengalami penurunan. Jika hal tersebut tidak segera mendapat penanganan yang tepat, maka ginjal tersebut tidak akan mampu melakukan penyaringan pembuangan elektrolit tubuh. Penyakit gagal ginjal berkembang secara perlahan ke arah yang semakin buruk di mana ginjal tidak mampu lagi bekerja sebagaimana fungsinya (Ariani, 2016).

Komplikasi dari gagal ginjal kronik menurut (Padila, 2018):

- Gangguan keseimbangan elektrolit: Hiperkalemia, hipokalsemia
- Gangguan asam basa: asidosis
- Perikarditis, efusi pericardial dan tamponade jantung
- Hipertensi, anemia
- Perdarahan saluran cerna
- Penyakit tulang

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada gagal ginjal kronis menurut (Priscilla LeMone, Karen M. Burke, 2016; Susanti, 2019) yaitu:

- Urine:** Volume urin biasanya kurang dari 400 ml/24 jam (oliguria) atau urine tidak ada (anuria). Warna secara abnormal urine keruh disebabkan oleh pus, bakteri, lemak, partikel koloid, fosfat atau urat. Berat jenis urine: < 1,015, kreatinin menurun. Natrium: > 40 meq/L karena ginjal tidak mampu mereabsorpsi natrium. Protein: derajat tinggi proteinuria, terdapat oedem 3-4+, secara kuat menunjukkan kerusakan glomerulus.

- b. Darah:** BUN dan serum kreatinin digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan menilai perkembangan kerusakan ginjal. Nilai BUN 20-50 mg/dl menandakan azotemia ringan; level lebih besar dari 100 mg/dl mengindikasikan kerusakan ginjal berat; level BUN berkisar ≥ 200 mg/dl menjadi gejala uremia. Nilai serum kreatinin ≥ 4 mg/dl mengindikasikan bahwa terjadi kerusakan ginjal serius (Najikhah & Warsono, 2020). Nilai dan rujukan kadar ureum dan nilai rujukan kadar kreatinin dijelaskan seperti tabel 1 dan 2 sebagai berikut :

Tabel 1 Nilai Rujukan Kadar Ureum

Spesimen	Nilai Rujukan	
Plasma atau serum	6-20 mg/dl	2,1-7,1 mmol
Urine 24 jam	12-20 g/hari	urea/hari 0,43-0,71 mmol urea/hari

Tabel 2 Nilai Rujukan Kadar Kreatinin

Populasi	Sampel	Metode Jaffe	Metode Enzimatik
Pria dewasa	Plasma dan ureum	0,93-1,3 mg/dL (80-115 $\mu\text{mol/L}$)	0,6-1,1 mg/dL (55-96 $\mu\text{mol/L}$)
	Urine 24 jam	800-2000 mg/hari (7,1-17,7 mmol/hari)	
Wanita dewasa	Plasma dan ureum	0,6-1,1 mg/dL (53-97 $\mu\text{mol/L}$)	0,5-0,8 mg/dL (40-66 $\mu\text{mol/L}$)
	Urine 24 jam	600-1.800 mg/hari (5,3-15,9 mmol/hari)	
Anak	Plasma dan ureum	0,3-0,7 mg/dL (27-62 $\mu\text{mol/L}$)	0,0-0,6 mg/dL (0-52 $\mu\text{mol/L}$)

Sumber: (Najikhah & Warsono, 2020)

- Hitung darah lengkap, Hb menurun pada adanya anemia
- Sel darah merah, menurun pada defisien eritropoetin seperti azotemia.
- GDA, pH menurun, asidosis metabolik (kurang dari 7,2) terjadi karena kehilangan kemampuan ginjal untuk mengeksresi hydrogen dan amonia atau hasil akhir katabolisme prtein, bikarbonat menurun, PaCO_2 menurun.
- Kalium, peningkatan sehubungan dengan retensi sesuai perpindahan seluler (asidosis) atau pengeluaran jaringan)
- Kalsium menurun

- f. Protein (khusus albumin), kadar serum menurun dapat menunjukkan kehilangan protein melalui urine, perpindahan cairan, penurunan pemasukan atau sintesa karena kurang asam amino esensial.
- g. Osmolaritas serum: lebih besar dari 285 mOsm/kg, sering sama dengan urin.

7. Penatalaksanaan Medis

Menurut (Mary, 2008) penatalaksanaan pasien Gagal Ginjal Kronik dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

a. Pengendalian cairan

Perubahan kemampuan untuk mengatur air dan mengekskresi natrium merupakan tanda awal gagal ginjal. Biasanya, pasien CRF mengalami hipervolemia akibat ginjal yang tidak mampu mengekskresikan natrium dan air. Namun dan air sehingga mengalami hipovolemia. Tujuan pengendalian cairan adalah mempertahankan status norotensif (tekanan darah dalam batas normal) dan status normovolemik (volume cairan dalam batas normal).

Pembatas asupan cairan pada pasien gagal ginjal kronik, sangat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya edema dan komplikasi kardiovaskular. Air yang masuk ke dalam tubuh dibuat seimbang dengan air yang keluar, baik melalui urin maupun IWL. Dalam melakukan pembatasan asupan cairan, bergantung dengan haluaran urin dalam 24 jam dan ditambahkan dengan IWL, ini merupakan jumlah yang diperbolehkan untuk pasien dengan gagal ginjal kronik yang mendapat dialysis. Misalnya: jika jumlah urin yang dikeluarkan dalam waktu 24 jam adalah 400 ml, maka asupan cairan total sehari adalah $400 + 500 \text{ ml} = 900 \text{ ml}$.

Makanan cair dalam suhu ruang (agar-agar, soup dan es krim) dianggap cairan yang masuk. Pasien GJK yang memperoleh terapi hemodialisis harus mengatur asupan cairan, sehingga berat badan tidak lebih dari 1,5 kg diantara waktu dialysis. Mengontrol asupan cairan termasuk salah satu masalah bagi pasien dengan terapi dialysis, karena dalam kondisi normal manusia tidak dapat bertahan lebih lama tanpa asupan cairan dibandingkan dengan makanan. Tapi bagi penderita penyakit gagal ginjal kronik harus membatasi asupan cairan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ginjal sehat melakukan tugasnya menyaring dan menabung limbah dan racun ditubuh kita dalam bentuk urin 24 jam, apabila fungsi ginjal terganggu maka terapi HD yang menggantikan tugas tersebut.

Mayoritas pasien yang mendapatkan terapi HD di Indonesia dilakukan dialysis dalam 2x/minggu, dan 4-5 jam perkali dialysis, itu artinya tubuh harus menanggung kelebihan cairan diantara dua waktu terapi. Apabila

pasien tidak membatasi jumlah asupan cairan yang terdapat dalam minuman maupun makanan, maka cairan akan menumpuk di dalam tubuh dan akan menimbulkan edema di sekitar tubuh. Kondisi ini akan membuat tekanan darah meningkat dan memperberat kerja jantung. Penumpukan cairan juga akan masuk ke paru-paru sehingga membuat pasien mengalami sesak nafas, karena itu pasien perlu mengontrol dan membatasi jumlah asupan cairan yang masuk dalam tubuh. Pembatasan tersebut penting agar pasien tetap merasa nyaman saat sebelum, selama dan sesudah terapi hemodialisis.

Penambahan berat badan antara dua waktu dialysis merupakan salah satu indikator kualitas bagi pasien HD yang perlu dikaji, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan perawatan kelanjutan diantara dua waktu dialysis dan meningkatkan kepatuhan terhadap pembatasan cairan. Kelebihan cairan yang terjadi dapat dilihat dari terjadinya penambahan berat badan secara cepat. Penambahan berat badan 2% dari berat badan normal merupakan kelebihan cairan ringan, penambahan berat badan 4% merupakan kelebihan cairan sedang, penambahan 6% merupakan kelebihan cairan berat.

Asupan cairan membutuhkan regulasi yang hati-hati dalam gagal ginjal lanjut, karena rasa haus pasien merupakan panduan yang tidak dapat diyakini mengenai keadaan hidrasi pasien. Berat badan harian merupakan parameter penting yang dipantau, selain catatan yang akurat mengenai asupan dan keluaran. Asupan yang terlalu bebas dapat menyebabkan kelebihan beban sirkulasi, edema dan intoksikasi cairan. Asupan yang kurang dari optimal dapat menyebabkan dehidrasi, hipotensi, dan pemburukan fungsi ginjal.

b. Pengendalian Elektrolit

1) Hiperkalemia

Kadar kalium plasma pada hiperkalemia dalam lebih dari 5,5 mEq/L. Pada pasien dengan CRF, retensi kalium terjadi karena nefron kurang mampu melakukan ekskresi. Hiperkalemia dapat dikendalikan dengan mengurangi asupan makanan yang kaya dengan kalium (pisang, jeruk, kentang, kismis, dan sayuran berdaun hijau) atau hemodialisis dengan dialisat tanpa mengandung kalium plasma yang dapat segera mengambil kalium dalam tubulus pasien.

2) Asidosis metabolik

Asidosis metabolik terjadi karena nefron yang rusak tidak dapat mengekskresikan asam yang dihasilkan dari metabolisme tubuh. Apabila laju filtrasi glomerulus menurun sampai 30-40%, asidosis metabolik mulai berkembang karena kemampuan tubulus distal untuk mereabsorpsi bikarbonat menurun. Walaupun terjadi retensi ion hydrogen dan hasilnya bikarbonat, Ph

plasma masih dapat dipertahankan karena tubuh mempunyai mekanisme pendaparan (*buffering*).

3) Hipokalsemia/ Hipofosfatemia

Pada gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk mengekskresi fosfor berkurang. Siklus hipokalsemia/ hipofosfatemia membuat demineralisasi tulang. Kalsium dan fosfor dikeluarkan dalam darah. Berkurangnya laju filtrasi glomerulus mengakibatkan peningkatan fosfat plasma, sekaligus penurunan kalsium serum. Penurunan kadar kalsium serum akan menstimulasi sekresi hormone paratroid dengan akibat kalsium di resorpsi dari tulang. Ginjal tidak mampu mengekskresikan sintesis vitamin D ke bentuk yang aktif, yaitu 1,25 dihidroksikolekalsifero. Vitamin D yang aktif ini diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dari traktus gastrointestinal dan menyimpan kalsium dalam tulang. Gangguan ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan (pada anak-anak), nyeri tulang, dan osteodistrofi ginjal pada orang dewasa. Tujuan terapi adalah menurunkan fosfor serum ke batas normal.

D. Asuhan Keperawatan pada Agregat Dewasa dengan Gagal Ginjal Kronis (GGK)

1. Pengkajian Individu dan Kelompok

a. Pengkajian Individu

1) Demografi.

Data demografi berupa nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, status pernikahan, agama dan lain sebagainya dari data demografi kita bisa mendapatkan data diri pasien untuk menunjang proses asuhan keperawatan selanjutnya.

2) Riwayat penyakit yang diderita klien sebelum mengalami CKD

Apakah mengalami penyakit Diabetes Melitus, glomerulo nefritis, hipertensi, reumatik, hiperparatiroidisme, obstruksi saluran kemih, dan traktus urinarius bagian bawah memungkinkan terjadinya CKD.

3) Pengkajian Bio-psiko-Sosial

a) Aktivitas istirahat

Gejala : kelelahan ekstrem kelemahan dan malaise, gangguan tidur (insomnia/ gelisah atau somnolen).

Tanda: kelemahan otot, kehilangan tonus, penurunan rentang gerak

b) Sirkulasi

Gejala : Riwayat hipertensi lama atau berat, palpitasi : nyeri dada (angina)

Tanda : Hipertensi : nadi kuat, edema jaringan umum dan pitting pada kaki, telapak tangan, nadi lemah dan halus, hipotensi ortostatik menunjukkan hipovolemia yang jarang terjadi pada penyakit tahap akhir, friction rub

pericardial (respon terhadap akumulasi rasa) pucat, kulit coklat kehijauan, kuning, kecenderungan pendarahan.

c) Integritas Ego

Gejala : Faktor stres, contoh finansial, hubungan, dan sebagainya. Peran tak berdaya, tak ada harapan, tak ada kekuatan

Tanda : Menolak, ansietas, takut, marah, mudah terangsang perubahan kepribadian.

d) Eliminasi

Gejala : Peningkatan berat badan cepat (edem), penurunan berat badan (malnutrisi). Anoreksia, Malnutrisi, kembung, diare, konstipasi.

Tanda : Perubahan warna urin, contoh kuning pekat, merah, coklat, berwarna. Oliguria, dapat menjadi anuria.

e) Makanan / Cairan

Gejala : Peningkatan berat badan cepat (edem), penurunan berat badan (malnutrisi). Anoreksia, nyeri ulu hati, mual / muntah, rasa metalik tidak sedap pada mulut (pernafasan amonia), penggunaan diuretik.

Tanda : Distensi abdomen / asietas, pembesaran hati (tahap akhir). Perubahan turgor kulit. Edem (umum, tergantung). Ulserasi gusi, pendarahan gusi / lidah. Penurunan otot, penurunan lemak subkutan, tampak tak bertenaga.

f) Neorosensasi

Gejala : Sakit kepala, penglihatan kabur, kram otot / kejang : sindrom Kaki, gelisah, kebas terasa terbakar pada telapak kaki. Kebas kesemutan dan kelemahan, khususnya ekstremitas bawah (neuropati perifer).

Tanda : Gangguan sistem mental, contoh penurunan lapang perhatian, ketidakmampuan berkonsentrasi, kehilangan memori, kacau, penurunan tingkat kesadaran, koma. Kejang, fasikulasi otot, aktifitas kejang, Rambut tipis, kuku rapuh dan tips.

g) Nyeri / Kenyamanan

Gejala : Nyeri panggul, sakit kepala, kram otot / nyeri kaki. Memburuk pada malam hari.

Tanda : perilaku berhati-hati dan gelisah.

h) Pernafasan

Gejala : nafas pendek : dipsnea, nokturnal parosimal, batuk dengan / tanpa sputum kental atau banyak.

Tanda : takiepna, dispnea, peningkatan frekuensi / kedalaman (Pernafasan kusmaul). Batuk produktif dengan sputum merah muda encer (edema paru).

i) Keamanan

Gejala : Kulit gatal ada / berulamngnya infeksi

Tanda : Pruritus Demam (sepsis, dehidrasi; normotemia dapat secara actual terjadi peningkatan pada klien yang mengalami suhu tubuh lebih rendah dari pada normal (efek CKD / depresi respon imun) Ptekie, araequimosi pada kulit Fraktur tulang; defosit fosfat, kalsium, (klasifikasi metastatik) pada kulit, jaringan lunak sendi, keterbatasan gerak sendi.

j) Seksualitas

Gejala : penurunan libido; amenorea; infertilitas.

k) Interaksi Sosial

Gejala : Kesulitan menentukan kondisi, contoh tak mampu bekerja, mempertahankan fungsi peran biasanya dalam keluarga

Pemeriksaan fisik

1) Keadaan umum pasien.

Yaitu pasien terlihat lemah, perlu bantuan untuk beraktivitas, adanya penurunan sensifitas nyeri. Kesadaran pasien dari compos mentis hingga coma.

2) Tanda-tanda vital.

Yaitu didapatkan tekanan darah naik, Rr naik, dan terjadi dispnea, peningkatan nadi dengan irama reguler.

3) Antropometri.

Yaitu terjadi penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir akibat kekurangan nutrisi, dapat juga terjadi peningkatan berat badan disebabkan kelebihan cairan.

4) Kepala

Yaitu dapat dilihat keadaan rambut kotor, mata ikterik / kotor, telinga kurang bersih, hidung kotor, mulut bau ureum, bibir kering dan pecah-pecah, mukosa mulut pucat dan lidah kotor.

5) Leher dan tenggorok.

Yaitu dapat dilihat adanya pembesaran tiroid pada leher.

6) Dada

Yaitu adanya sesak sampai pada edema pulmonal, dada berdebar-debar. Terdapat otot bantu napas, pergerakan dada tidak simetris, terdengar suara tambahan pada paru (rongkhi basah), terdapat pembesaran jantung, terdapat suara tambahan pada jantung.

7) Abdomen

Yaitu Terjadinya peningkatan nyeri, penurunan peristaltic usus, pembesaran abdomen.

8) Genital.

Yaitu terjadinya kelemahan dalam seksualitas, kebersihan genetalia tidak terjaga, ejakulasi dini, impotensi, terdapat ulkus

9) Ekstremitas

Yaitu dapat dilihat dengan adanya kelemahan fisik, aktifitas klien dibantu, terjadi edema, pengeroposan tulang, dan Capillary Refill lebih dari 1 detik.

10) Kulit.

Yaitu dapat dilihat turgor kulit jelek, terjadi edema, kulit jadi hitam, kulit bersisik / uremia, dan terjadi perikarditis.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada klien dengan Chronic Kidney Disease (CKD) menurut Trucker (2008) dalam Sudoyo (2015) yaitu sebagai berikut:

- 1) Urinalisasi : akan didapatkan hasil PH asam, SDP, SDM, berat jenis urin (24 jam) : volume normal, volume kosong atau rendah, proteiurea, penurunan klirens kreatinin kurang dari 10 ml permenit menunjukkan kerusakan ginjal yang berat.
- 2) Hitungan darah lengkap : akan didapatkan hasil penurunan hematokrit / HB , trombosit, leukosit, peningkaanj SDP.
- 3) Pemeriksaan urin : akan didapatkan hasil Warna PH, kekeruhan, glukosa, protein, sedimen, SDM, keton, SDP, CCT.
- 4) Kimia darah : akan didapatkan hasil kadar BUN, kreatinin, kalium, kalsium, fosfor, natrium, klorida abnormal.
- 5) Uji pencitraan : akan didapatkan hasil IVP, ultrasonografi ginjal, pemindaian ginjal, CT scan.
- 6) EKG : akan didapatkan hasil distritmia
- 7) Poto polos abdomen, akan ditemukan batu radio opak
- 8) Pielografi intra vena jarang dikerjakan, karena kontras tidak dapat melewati filter glomerulus, disamping keawatiran terjadinya pengaruh toksik oleh kontras terhadap ginjal yang sudah mengalami kerusakan.

b. Pengkajian Kelompok

- **Data Inti**

Data inti yang dikaji terdiri atas sejarah/riwayat yang meliputi riwayat daerah dan perubahan daerah. Data inti mencakup demografi, karakteristik, umur dan sex, serta vital statistic. Data demografi kelompok atau komunitas terdiri dari jumlah penduduk dengan penyakit gagal ginjal kronik dan wilayah, umur, pendidikan, jenis kelamin, vital statistic, pekerjaan, agama, nilai-nilai, keyakinan serta riwayat timbulnya kelompok atau komunitas.

- a) Jumlah penduduk, jumlah penduduk tempat penderita gagal ginjal kronik berada, contohnya jumlah penduduk di Jawa Tengah:

Jumlah penduduk : 347.18.204 jiwa
Laki-Laki : 17.212.455 jiwa
Perempuan : 17.505.749 jiwa

- b) Usia

Semakin tua umur seseorang maka persentase untuk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Kondisi ini akan meningkatkan ketergantungan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Individu yang memiliki keluarga dan tinggal bersama, semua permasalahan yang terjadi akan dapat dibantu oleh keluarga. Namun karena suatu hal individu dengan penyakit gagal ginjal kronis yang tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga tetapi tidak mampu merawat dan memenuhi kebutuhannya, maka akan tinggal di Panti bila sudah lansia ataupun tinggal sendiri di rumah

- c) Karakteristik jenis kelamin

Laki-laki yang mengalami penurunan pendapatan cenderung berisiko depresi lebih tinggi dibandingkan perempuan karena laki-laki merupakan kepala keluarga yang berperan besar dalam keluarga.

- d) Tipe keluarga meliputi keluarga/bukan keluarga dan kelompok.

- e) Status perkawinan meliputi kawin, janda/duda, single.

- f) Statistic vital meliputi kelahiran, kematian kelompok usia dan penyebab kematian. Serta nilai-nilai, keyakinan, dan agama.

- g) Pendidikan penduduk, penduduk mayoritas berpendidikan hingga lulus SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi.

- h) Suku Bangsa, suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya.

- i) Nilai dan kepercayaan, nilai dan norma masyarakat/penduduk masih mengenal nilai kesopanan, gotong royong dan kerukunan antar warganya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang masih terus berjalan seperti kerja bakti, arisan, dan takziah.

- j) Agama, mayoritas penduduk/masyarakat beragama Islam atau beberapa beragama Kristen atau agama lainnya dan juga sebaliknya sesuai dengan agama dari penduduk/masyarakat.

- **Data sub sistem**

Data subsistem yang perlu dikaji menurut (Mengistu & Misganaw, 2006) antara lain sebagai berikut;

- a) Lingkungan fisik/Perumahan

Pengkajian lingkungan fisik sama seperti pemeriksaan fisik yang penting bagi pasien individu, begitu juga pemeriksaan fisik di lingkungan hidup masyarakat. Lima indera digunakan dalam penilaian fisik yaitu pemeriksaan inspeksi, auskultasi, tanda vital, tinjauan sistem, dan studi laboratorium.

- (1) Inspeksi: pemeriksaan menggunakan semua organ indera dan dilakukan dengan survey berjalan di masyarakat, atau penilaian mikro terhadap perumahan, ruang terbuka, batas, pusat layanan transportasi, pasar, bertemu orang jalanan, tanda-tanda pembusukan, etnisitas, agama, kesehatan dan mordibitas, media politik.
- (2) Auskultasi: mendengarkan warga sekitar lingkungan fisik.
- (3) Tanda vital: mengamati iklim, medan, batas alam seperti sungai dan bukit. Sumber daya masyarakat: mencari tanda-tanda kehidupan seperti pemberitahuan, poster, perumahan baru dan bangunan.
- (4) Sistem review: usia hosing, arsitektur, bekas bahan bangunan, tanda-tanda kerusakan, air mengalir, pipa ledeng, sanitasi, jendela (gelas) dan lain-lain, juga fasilitas bisnis dan gereja.
- (5) Studi laboratorium: sensus data atau studi perencanaan untuk pemetaan masyarakat.

Beberapa hal yang dikaji di lingkungan fisik/perumahan adalah sebagai berikut:

- (1) Kualitas udara
Keadaan udara di daerah tempat tinggal beriklim sejuk atau panas, apakah terdapat polusi udara yang dapat mengganggu pernafasan warga atau tidak.
- (2) Kualitas air
Sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keadaan saluran air disekitar rumah.
- (3) Tingkat kebisingannya
Adanya sumber suara atau bising yang dapat mengganggu keadaan penderita gagal ginjal kronik contohnya seperti pabrik.
- (4) Jarak antar rumah/kepadatan
Jarak antar rumah satu dnegan yang lainnya, apakah saling berdempetan.

b) Pendidikan

Pada penderita gagal ginjal kronik tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pendapatan uang bulanan dan mekanisme koping yang dilakukan. Riwayat pendidikan, pendidikan terakhir dan juga apakah ada

sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan warga.

c) Keamanan dan Transportasi

Pengkajian keamanan dan transportasi meliputi polisi, sanitasi (sumber air, pembuangan limbah padat, limbah dan kualitas udara) dan layanan pemadam kebakaran. Keadaan penjagaan lingkungan sekitar seperti adanya siskamling, satpam atau polisi. Apakah dari keamanan tersebut menimbulkan stress atau tidak. Sarana transportasi yang digunakan warga untuk mobilasi sehari-hari menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi seperti berjalan, taksi, bus, kereta api, mobil pribadi, dan layanan udara. Frekuensi dan keterjangkauan masyarakat atau transportasi pribadi dan standar jalan.

d) Politik dan Pemerintahan

Pengkajian politik dan pemerintahan meliputi kebele, asosiasi petani, aliansi bisnis, kelompok religius, asosiasi pemuda dan wanita, asosiasi etika, aktivisme politik, dan lain-lain, menggambarkan tujuan dan aktivitas asosiasi. Kebijakan yang ada di daerah tersebut apakah cukup menunjang sehingga memudahkan komunitas mendapat pelayanan di berbagai bidang termasuk kesehatan.

e) Pelayanan Kesehatan dan Sosial

Bedakan antara fasilitas di lokasi masyarakat dan diluar lokasi. Rumah sakit meliputi jumlah tempat tidur, kepegawaian, anggaran, puskesmas, klinik, atau pos kesehatan, layanan kesehatan masyarakat, klinik swasta, apotik, klinik gigi, dan jasa lainnya. Tanda obat atau penyalahgunaan zat, alkoholisme. Pelayanan sosial meliputi penyuluhan dan dukungan, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan khusus, serta pasar dan pertokoan. Tersedianya tempat pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi dini gangguan atau merawat atau memantau apabila gangguan sudah terjadi serta karakteristik pemakaian fasilitas pelayanan kesehatan.

f) Sistem Komunikasi

Pengkajian komunikasi terdiri atas formal dan informal. Komunikasi formal meliputi surat kabar, radio, televisi, telepon, internet, dan hotline. Komunikasi informal meliputi papan pengumuman, poster, brosur, pengeras suara dari masjid, dll. Sarana komunikasi apa saja yang dapat dimanfaatkan di komunitas tersebut untuk saling berkomunikasi antar warga atau mendapat informasi dari luar misalnya televisi, radion, Koran, atau leaflet yang diberikan kepada komunitas.

g) Ekonomi

Pekerjaan terdahulu dan penghasilan pekerjaan penderita gagal ginjal kronik sebelum pension bila lansia atau sesudah berhenti bekerja perlu

dikaji. Tidak semua pekerjaan apalagi yang bukan pegawai mendapat pensiun. Selain itu jumlah uang pensiunan juga dapat mempengaruhi tingkat stress dan depresi pada lansia. Tingkat social ekonomi komunitas secara keseluruhan, masih bekerja atau tidak, bagaimana dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

h) Rekreasi

Pengkajian rekreasi meliputi fasilitas seperti stadion, area rekreasi, lapangan bola voli, taman bermain, area piknik, museum, musik/tarian, teater/bioskop. Apakah tersedia sarannya, kapan saja dibuka, dan apakah biayanya terjangkau oleh komunitas. Rekreasi ini hendaknya dapat digunakan komunitas untuk mengurangi stress.

2. Diagnosis Keperawatan

- a. Defisit kesehatan komunitas pada penderita gagal ginjal kronik di Puskesmas..... (D.0110)
- b. Manajemen kesehatan tidak efektif pada penderita gagal ginjal di Desa..... (D.0116)
- c. Pemeliharaan Kesehatan tidak efektif pada penderita gagal ginjal di Desa..... (D.0117)
- d. Defisit pengetahuan pada penderita gagal ginjal kronik di Desa.... (D.0111)

3. Intervensi Keperawatan pada Kelompok

- a. Defisit kesehatan komunitas

Tujuan : Setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit diharapkan deficit kesehatan komunitas teratasi

Kriteria Hasil

Status kesehatan komunitas (L.12109)

- 1) Ketersediaan program promosi kesehatan masyarakat dari kurang menjadi meningkat
- 2) Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan komunitas dari kurang menjadi meningkat
- 3) Kepatuhan masyarakat terhadap standar kesehatan lingkungan dari kurang menjadi meningkat
- 4) Perilaku coping dari masyarakat dari yang kurang menjadi meningkat

Intervensi

Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)

1) *Self Help Group*

- a) Identifikasi masalah atau isu kesehatan dalam masyarakat dan prioritasnya

- b) Berikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi sesuai asset yang dimiliki
- c) Berikan saran kepada masyarakat untuk membatasi pemasukan cairan setiap harinya

2) *Support Group*

- a) Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang gagal ginjal kronis dan diet yang dianjurkan
- b) Libatkan anggota masyarakat dalam musyawarah untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu dan masalah kesehatan yang dihadapi
- c) Pertahankan komunikasi yang terbuka dengan anggota masyarakat dan pihak yang terlibat

3) *Kemitraan*

Jalin kerjasama dengan pelayanan kesehatan untuk pemberian pengobatan gratis untuk masyarakat

b. Manajemen kesehatan tidak efektif

Tujuan : Setelah dilakukan penyuluhan selama 30 menit diharapkan manajemen keperawatan tidak efektif teratasi

Kriteria hasil

Pemeliharaan kesehatan (L.12106) dan Perilaku Promosi Kesehatan (L.1602)

- 1) Perilaku kesehatan masyarakat dari yang buruk membaik
- 2) Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perilaku sehat dari kurang menjadi meningkat
- 3) Peningkatan skrining kesehatan masyarakat yang kurang menjadi meningkat
- 4) Terjadi peningkatan keseimbangan aktivitas dan latihan masyarakat dari kurang menjadi meningkat

Intervensi

Skrining Kesehatan (I.6520) dan Edukasi Kesehatan (I.12383)

1) *Self Help Group*

- a) Ukur tekanan darah
- b) Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

2) *Support Group*

Beri saran kepada masyarakat dengan hasil yang lebih dari normal untuk melakukan alternative pengobatan

3) *Kemitraan*

Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

c. Pemeliharaan Kesehatan tidak efektif

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan selama 30 menit diharapkan perilaku kesehatan cenderung beresiko dapat teratasi

Kriteria Hasil

Kepercayaan Mengenai Kesehatan: Kontrol yang diterima (L.1702)

- 1) Kemampuan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawab terkait dengan keputusan kesehatan dari kurang menjadi meningkat
- 2) Peningkatan keyakinan bahwa tindakan sendiri yang mengontrol hasil kesehatan yang semula kurang menjadi meningkat
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam keputusan kesehatan yang kurang menjadi meningkat

Intervensi

Peningkatan Efikasi Diri (I.5395)

1) *Self Help Group*

- a) Identifikasi hambatan untuk merubah perilaku
- b) Bantu individu untuk berkomitmen terhadap rencana tindakan untuk merubah perilaku

2) *Support Group*

Berikan contoh atau tunjukkan perilaku yang diinginkan mengenai perilaku yang diinginkan

3) Kemitraan

Berikan informasi mengenai perilaku yang diinginkan

d. Defisit pengetahuan

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan selama 30 menit diharapkan tingkat pengetahuan masyarakat menjadi meningkat

Kriteria Hasil:

Tingkat pengetahuan (L.12111)

- 1) Perilaku masyarakat sesuai dengan pengetahuan dari yang kurang menjadi meningkat
- 2) Kemampuan masyarakat dalam menjelaskan pengetahuan tentang suatu topic menjadi meningkat

Intervensi:

Edukasi Kesehatan (I.12384)

1) *Self Help Group*

- a) Sediakan materi dan media yang akan digunakan untuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat
- b) Berikan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan tentang gagal ginjal kronis kepada masyarakat

2) *Support Group*

- a) Anjurkan masyarakat melakukan program skrining lingkungan
- b) Berikan kesempatan masyarakat untuk bertanya mengenai materi yang telah diberikan.

3) Kemitraan

Kolaborasi dengan pelayanan kesehatan terkait dengan pemberian contoh ataupun model dalam proses penyuluhan kesehatan

4. Implementasi

PLAN OF ACTION (POA) INTERVENSI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT DESA
..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....

No. DX	Masalah	Tujuan	Kegiatan	Tempat	Waktu dan Sasaran	Penanggung jawab
1.	Defisit Kesehatan Komunitas	Selama dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu di Desa A Kec. B Kab. C diharapkan: Diharapkan meningkatkan derajat kesehatan komunitas	1. Identifikasi masalah atau isu kesehatan dan prioritasnya 2. Beri kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi sesuai asset yang dimiliki 3. Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang gagal ginjal kronis 4. Menjalin kerjasama dengan Puskesmas A untuk pemberian	Posko Kesehatan	Setiap hari Warga Setiap hari Warga Setiap hari Warga Setiap hari Warga	Perawat dan Masyarakat Perawat dan Masyarakat Perawat dan Masyarakat Perawat dan Masyarakat

			obat gratis untuk pasien			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

5. Evaluasi Keperawatan pada Kelompok

No.	Waktu	Jenis Kegiatan	Evaluasi Formatif
1.	Senin, 20 Desember 2022	Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah	Evaluasi struktur 1. Pemeriksaan dilakukan oleh mahasiswa praktikan yang bertempat di posko kesehatan 2. Kegiatan dilakukan setiap hari Evaluasi Proses 1. Pengecekan tekanan darah menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop 2. warga yang melakukan pemeriksaan sebelumnya didata dan dicek berat badan Evaluasi Hasil 1. Masyarakat sangat antusias dan mendatangi posko kesehatan untuk pengecekan tekanan darah 2. Tekanan darah pasien 140/90 mmHg 3. Dilakukan pengukuran berat badan, dan pendidikan kesehatan gagal ginjal kronis

- "Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah." -

Daftar Pustaka

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Penduduk Lansia. *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย*, 4(1), 88–100.
- Anderson, E. T., & McFarlane, J. (2014). Community as partner: Theory and practice in nursing. In *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*. <https://doi.org/10.1097/00000446-199610000-00015>
- Ariani, S. (2016). Stop Gagal Ginjal dan Gangguan-Gangguan Ginjal Lainnya: Seputar Ginjal dan Rogam Jenis Lainnya. In *Jogjakarta: Wirogunan*.
- CDC. (2015). *What is prevention?*
- Depkes RI. (2010). *Pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di puskesmas*.
- Edelman, Carole Lium; Mandle, Carol Lynn; and Kazer, M. W. (2006). *Health Promotion Throughout the Lifespan* (6th ed.). Mosby YearBook, Inc.
- Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (2010). Health promotion program. In *Journal of the Tennessee Medical Association* (Vol. 75, Issue 9).
- Fitriany, J., & Saputri, A. I. (2018). Anemia Defisiensi Besi. *Jurnal. Kesehatan Masyarakat*, 4(1202005126), 1–30.
- Hutagaol, E. V. (2017). Peningkatan Kualitas Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Terapi Hemodialisa Melalui Psychological Intervention di Unit Hemodialisa RS Royal Prima Medan Tahun 2016. *Jurnal Jumantik*, 2(1). <https://doi.org/10.1080/13507486.2015.1047603>
- Indrasari, D. N. (2015). Perbedaan Kadar Ureum dan Kreatinin Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Berdasarkan Lama Menjalani Terapi Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*.
- Kaneto, H. (2015). Pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. In *Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine* (Vol. 73, Issue 12, pp. 2003–2007). <https://doi.org/10.1093/med/9780199235292.003.1336>
- Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia 2019. In *Journal of Chemical*
- Maglaya, A. S. (2009). *Nursing Practice in the Community* (Fifth). Argonauta Corporation.
- Mansjoer, A. (2014). Kapita Selekt Kedokteran Edisi IV. In *Jakarta: Media Aesculapius*.
- Mary, B. (2008). Klien Gangguan Hati. Seri Asuhan Keperawatan. In *Jakarta : EGC*. <https://doi.org/10.1017/S1368980008002401>
- Monks, F. ., Knoers, A. M. ., & Hadinoto, S. R. (2019). *Psikologi perkembangan: pengantar dalam berbagai bagiannya* (18th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Najikhah, U., & Warsono, W. (2020). Penurunan Rasa Haus Pada Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) Dengan Berkumur Air Matang. *Ners Muda*, 1(2), 108. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5655>
- Padila. (2018). Buku Ajar Keperawatan Keluarga. In *Yogyakarta: Nuha Medika*.

- Paolisso, G. (2010). Pathophysiology of diabetes in elderly people. *Acta Biomedica*, 81(SUPPL. 1), 47–53.
- Papalia, D. E. (2004). *Human Development* (9th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Permanasari, N. (2012). *Asuhan Keperawatan Pada Ny. M Dengan Chronic Kidney Disease di Ruang Hemodialisa RSUD DR. Moewardi Surakarta*.
- PERNEFRI. (2018). 11th report Of Indonesian renal registry 2018. *Indonesian Renal Registry (IRR)*, 14–15.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PPNI. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan* (1st ed.). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Price A Sylvia dan Wilson, L. M. (2012). Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit Edisi 6. In *Jakarta: EGC*.
- Priscilla LeMone, Karen M. Burke, G. B. (2011). *Medical-Surgical Nursing: Critical Thinking in Patient Care 5th Edition*. In *New Jersey: Pearson Prentice Hall*.
- Priscilla LeMone, Karen M. Burke, G. B. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. In *Jakarta : EGC*.
- Riskesdas. (2018). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar. *Kementrian Kesehatan RI*, 1–582.
- Smeltzer, S. C. dan B. G. B. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddart*. In *Jakarta: EGC*.
- Susanti, K. dan. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah 1*. In *Yogyakarta : Pustaka Baru*.
- World Health Organization. (2018). WHO - The top 10 causes of death. In *24 Maggio* (pp. 1–7). <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT DEWASA DENGAN TUBERKULOSIS (TB) PARU



Asuhan Keperawatan Komunitas pada Agregat Dewasa dengan Tuberkulosis (TB) Paru

A. Tujuan Penulisan

Setelah membaca topik asuhan keperawatan pada agregat dewasa dengan tuberkulosis (TB) paru maka pembaca mampu memahami tentang konsep penyakit TB, proses asuhan keperawatan komunitas pada dewasa dengan TB paru serta berbagai inovasi yang mendukung perawat komunitas dalam penatalaksanaannya. Asuhan keperawatan komunitas ini disusun berdasarkan penulisan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

B. Fenomena Penyakit Tuberkulosis

Diperkirakan 9,9 juta pasien menderita tuberkulosis di seluruh dunia (127/100.000 penduduk) pada tahun 2020. Sebagian besar kasus tuberkulosis secara geografis pada tahun 2020 (43%) terjadi di Asia Tenggara dan Afrika. 30 negara dengan insiden TB tertinggi menyumbang 86% dari semua perkiraan kasus insiden di seluruh dunia, dengan delapan negara ini menyumbang dua pertiga dari total global (India, Cina, Indonesia, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Afrika Selatan (WHO, 2021). TB adalah penyebab kematian terbesar ke-13 secara global dan penyebab utama terkait agen infeksi. Secara global, diperkirakan 1,3 juta pasien TB dengan orang HIV-negatif meninggal pada tahun 2020. 85% dari total kematian akibat TB berasal dari wilayah Afrika dan Asia Tenggara (WHO, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang angka kejadian tuberkulosis terbesar. Angka kejadian tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2020 adalah 301 per 100.000 penduduk, dan angka kematian penderita tuberkulosis adalah 34 per 100.000 penduduk. (WHO, 2021). Pada tahun 2020 jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 351.936 kasus, menurun dibandingkan seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 568.987 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus tuberkulosis paru sebanyak 165.116 (IMoH, 2021). Jumlah kasus terbanyak dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut hampir mencapai setengah dari total kasus tuberkulosis di Indonesia (46%) (ImoH, 2020).

Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan prevalensi kasus tuberkulosis tertinggi. Jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 45.669 kasus dengan tingkat kejadian 107 per 100.000 penduduk (ImoH, 2021). Sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 3,6 per 100.000 penduduk (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2020). Pada tahun 2020 kasus tuberkulosis paru di Jawa Timur sebanyak 20.962 kasus (IMoH, 2020). Dari 38

kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak kedua setelah Kota Surabaya pada tahun 2019 sebanyak 3047 kasus (139/100,00 penduduk) (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2020). Pada tahun 2021, jumlah kejadian TB di Kabupaten Jember menurun sebanyak 2356 kasus (Dinkes Jember, 2021). Kasus TB Paru di Kabupaten Jember sebanyak 2.908 (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2020)

C. Konsep Penyakit Tuberkulosis

1. Definisi Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis (TB) adalah infeksi serius yang menjadi penyebab utama penyakit dan kematian secara global. Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, bersama dengan HIV dan COVID-19, penyebab utama kematian akibat penyakit menular secara global (Organisasi Kesehatan Dunia, 2021). TBC disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang dibawa melalui udara oleh penderita TBC (WHO, 2021).

Meskipun tuberkulosis paling sering dikaitkan dengan paru-paru (tuberkulosis paru), penyakit ini juga dapat menyerang organ lain (tuberkulosis ekstrapulmoner) seperti ginjal, otak, tulang, atau tulang belakang (CDC, 2011). Gejala utama penderita TB Paru adalah batuk aktif selama dua minggu atau lebih. Gejala tambahan berupa batuk darah, sesak napas, lemas, nyeri dada, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, malaise, keringat malam tanpa aktivitas fisik, dan demam (ImoH, 2019). Tuberkulosis dapat disembuhkan. Sekitar 85% penderita tuberkulosis dapat disembuhkan secara efektif dengan rejimen pengobatan enam bulan (WHO, 2021).

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh adanya bakteri jenis *mycobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru.

2. Etiologi Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis (TB) disebabkan oleh sekelompok bakteri yang disebut *Mycobacterium*. Mikobakteria yang menyebabkan TB pada manusia adalah *Mycobacterium tuberculosis*. TB dapat menyerang bagian tubuh manapun. Jika menyerang sisi paru-paru, maka disebut TB milier. Sedangkan TB yang menyerang selain paru disebut TB extra-pulmonal. TB pulmonal ditemukan hampir 60% dari kasus penyakit dan penularannya karena transmisi infeksi (Fang et al., 2019)

3. Patofisiologi Tuberkulosis (TB)

Mycobacterium tuberculosis merupakan mikobakteria kecil tidak berspora, bentuk batang (agak cembung) yang disebut basil, organisme gram positif asam, yang memiliki dinding sel kaya lipid. Merupakan organisme aerob, sehingga lebih suka menyerang paru-paru. Selain mikobakteria di atas, ada mikobakteria yang tidak dapat menyebabkan

TB. Mikobakteria ini terdapat di tanah, air, debu, dan binatang. Namun dapat menyebabkan keparahan jika ada kerusakan paru sebelumnya karena mengalami immunocompromise seperti HIV. Ketika basil masuk kedalam alveoli akan ada reaksi inflamasi lokal dan fokus primer infeksi. Perpaduan keduanya ini disebut Ghon, dimana selanjutnya akan berkembang menjadi granuloma dan isi penuh dengan mikobakteria. Peradangan ini jika terus-menerus terjadi maka akan terjadi pneumonia akut yang selanjutnya akan berkembang menjadi infeksi tuberkulosis yang ditandai gejala umum pada TB (Ruru *et al.*, 2018).

Selama infeksi primer beberapa bakteri melewati nodus limfe regional pada hilum, yang merupakan tempat pembuluh darah dan syaraf menuju paru-paru. Dari sinilah yang nantinya akan menjadi asal terjadinya TB sekunder atau TB ekstra paru-paru. Secara kolektif, nodus limfe yang membesar dan Ghon disebut kompleks primer. Pembentukan granuloma merupakan mekanisme pertahanan alami dari tubuh yang bertujuan untuk mengisolasi infeksi. Sehingga lingkungan seperti ini diharapkan akan menghambat replikasi basilus dan menghentikan infeksi. Infeksi primer pada penderita dewasa imunokompeten yaitu penderita dengan imunitas host yang tinggi, mikobakteria terbunuh atau tidak dapat bereplikasi (Yang *et al.*, 2020). Sehingga mayoritas orang yang terserang TB tidak akan mengalami tanda dan gejala, 70% orang yang imunokompeten dapat membasmi basil keseluruhan. Sedangkan sisa bakteri yang masih ada disebut sebagai infeksi TB laten dimana bakteri tidak terbunuh, tetapi mengalami dormansi. Namun, 5-10% penderita dengan TB laten dapat menjadi aktif kembali. Individu dengan infeksi TB laten tidak terlihat sakit dan terinfeksi. Namun jika bakteri mulai mengganda selama beberapa bulan atau tahun kemudian, maka dapat menjadi aktif dan gejala sakit serta infeksi mulai terlihat (Ruru *et al.*, 2018).

4. Manifestasi Klinis

Gejala utama pasien TB Paru adalah batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Gejala Tambahan pasien TB Paru meliputi batuk mengeluarkan darah, demam berkepanjangan, sesak napas dan nyeri dada, berkeringat di malam hari walau tanpa aktifitas, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun (Gebreweld *et al.*, 2018).

Gejala dan tanda mengenai infeksi tuberkulosis aktif yaitu demam, keringat malam, batuk darah, sesak nafas, nyeri dada, dan adanya pembengkakan kelenjar getah bening (Gebreweld *et al.*, 2018).

5. Komplikasi Tuberkulosis (TB)

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat TB Paru adalah sebagai berikut (Yang *et al.*, 2020):

- a. Kerusakan paru-paru permanen: Kerusakan permanen pada paru-paru dapat terjadi bila tuberkulosis tidak segera ditangani atau bila pengobatannya tidak dijalani dengan baik.
- b. Penyebaran tuberkulosis ke organ lain: TBC yang tidak ditangani dapat menyebar luas ke organ lain dan menyebabkan komplikasi, seperti nyeri dan patah tulang belakang, kerusakan sendi, meningitis, gangguan kelenjar getah bening, gangguan pada hati atau ginjal, serta penyakit jantung.
- c. Kematian: TBC yang menyebar luas ke organ-organ lain berisiko menyebabkan kematian.

6. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Pemeriksaan dahak secara mikroskopis: Diagnosis definitif TB dilakukan dengan pemeriksaan kultur atau kultur sputum. Pemeriksaan kultur memakan waktu lebih lama (setidaknya enam minggu) dan mahal. Pemeriksaan langsung tiga spesimen sputum Sekali-Pagi-Sekali (SPS) secara mikroskopis menghasilkan nilai yang identik dengan pemeriksaan sputum secara kultur. Ini dilakukan dengan mengumpulkan tiga spesimen dahak yang diperoleh dalam dua hari dari Sekali-Pagi-Sekali (SPS) (Kemenkes, 2016).

- a. S (Sekali) : Dikumpulkan pada saat suspek TBC melakukan kunjungan pertama, dan pada saat cuti diberikan pot untuk pengambilan dahak pagi hari kedua.
- b. P (Pagi): Dikumpulkan di rumah pada pagi kedua. Sputum diambil dan diserahkan kepada petugas di fasilitas kesehatan segera setelah mereka bangun.
- c. S (Sekali): Dikumpulkan pada hari kedua sambil mengumpulkan sputum pagi hari.

7. PENATALAKSANAAN MEDIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016, strategi DOTS merupakan strategi penanggulangan TB nasional yang telah direkomendasikan oleh WHO pada tahun 1995. Strategi DOTS merupakan pengobatan dengan suplai OAT (Obat Anti Tuberkulosis) yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. minimal enam bulan. Pendekatan DOTS adalah pengawasan langsung terhadap pengobatan jangka pendek, dan menjadi tanggung jawab setiap pengelola program TB untuk memperhatikan (direct attention) guna mengidentifikasi pasien melalui pemeriksaan mikroskopis. Setiap pasien harus diawasi saat menelan obat, dengan setiap dosis yang digunakan di depan pengawas. Pengobatan TBC harus selalu meliputi pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan dengan maksud: (Kemenkes, 2019).

1. Tahap Awal: Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resistan sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2

bulan. Pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu pertama.

2. Tahap Lanjutan: Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman *persister* sehingga pasien. Diberikan selama 16 minggu.

Selama pengobatan TBC terdapat Pengawas Menelan Obat (PMO). PMO adalah orang yang dipilih berdasar kesepakatan pasien dan petugas kesehatan untuk mendampingi pasien dan mengawasi minum obat selama masa pengobatan. PMO menjadi mitra kader dalam mengidentifikasi kontak serumah dan kontak erat pasien. Pengawas Menelan Obat (PMO) telah dilakukan baik oleh petugas kesehatan maupun kader melalui kunjungan rumah. Namun pelibatan peran PMO belum dieksplorasi lebih jauh padahal PMO adalah orang terdekat pasien (Kemenkes, 2019).

D. Asuhan Keperawatan pada Agregat Dewasa dengan Tuberkulosis (TB) Paru

1. Pengkajian Individu dan Kelompok

a. Pengkajian Individu

Pengkajian individu ditujukan kepada setiap orang yang dicurigai memiliki tanda gejala dan keluhan TB. Pengkajian yang dilakukan meliputi anamnesa keluhan yang dirasakan klien, kemudian berat badan sebelum sakit hingga saat sakit apakah terjadi penurunan BB secara signifikan, kemudian pemeriksaan fisik *head to toe*, terutama pada bagian dada. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan lainnya yaitu pemeriksaan dahak, pemeriksaan darah, tes tuberkulin dan rontgen dada.

b. Pengkajian Kelompok atau Komunitas

Pengkajian adalah suatu kegiatan perawat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan pada klien. Pada pengkajian keperawatan komunitas dapat dilakukan pada sasaran individu dan kelompok yang berada pada kondisi resiko atau rentan terhadap suatu penyakit.

Pengkajian komunitas terdiri dari data inti komunitas yaitu demografi, statistik vital, sejarah, etnis/budaya dan persepsi kesehatan. Sedangkan subsistem terdiri dari lingkungan fisik, pendidikan, ekonomi, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan, pelayanan kesehatan dan sosial, komunikasi dan rekreasi.

Pengkajian komunitas didasarkan pada Model *Community as Partner* dengan fokus pada roda pengkajian komunitas. Roda pengkajian komunitas terdiri dari; inti komunitas (*the community core*) dan subsistem komunitas (*the community subsystems*).

- **Data inti**

- 1) Demografi: statistik vital (misalnya angka kelahiran, angka kesakitan dan angka kematian), komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
 - 2) Nilai: etnis budaya
 - 3) Kepercayaan: persepsi terhadap kesehatan
 - 4) Sejarah komunitas
- **Subsistem**
 - 1) Lingkungan fisik: iklim/cucaca, perumahan (kepadatan, kelembaban, pencahayaan, bangunan, lingkungan terbuka), batas wilayah dan tempat berkumpul.
 - 2) Pendidikan: fasilitas pendidikan yang digunakan masyarakat (jenis kepemilikan, tingkat institusi pendidikan), karakteristik pengguna, layanan yang disediakan, sumber-sumber yang dimiliki dan lokasi
 - 3) Ekonomi: karakteristik finansial (penghasilan keluarga berdasarkan upah minimum regional), pekerja (status, kategori, dan kelompok khusus pekerja).
 - 4) Keamanan dan transportasi: pelayanan dan perlindungan terhadap komunitas dikaitkan dengan kebakaran, kepolisian, krisis senter, dan sanitasi.
 - 5) Politik dan pemerintahan: partai politik dan partisipannya dalam pelayanan kesehatan, jenis pemerintahan, dan kebijakan kesehatan.
 - 6) Pelayanan kesehatan sosial: ketersediaan, jenis, waktu, sumber daya, dan karakteristik pembiayaan kesehatan dan sosial. pengguna serta.
 - 7) Komunikasi: cara komunitas (jenis, bentuk, frekuensi, lingkup dan cara melakukan komunikasi).
 - 8) Rekreasi: jenis, lokasi, penggunaan dan biaya.

Pengumpulan data kesehatan komunitas dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data primer: pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh perawat pada komunitas. Beberapa jenis pengumpulan data primer yaitu windshield survey/ observasi komunitas, wawancara, diskusi kelompok terarah, penyebaran angket /kuisisioner, dan pemeriksaan kesehatan (fisik dan mental).
- b. Pengumpulan data sekunder: pengumpulan data komunitas yang tidak langsung dilakukan oleh perawat, akan tetapi bersumberkan data dokumenter seperti demografi, profil wilayah, data epidemiologi.

Metode pengkajian komunitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Winshield survey digunakan untuk mengkaji kondisi lingkungan fisik komunitas melalui observasi

- b. Kuisioner digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari masyarakat langsung dengan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan data inti dan data susbsistem yang ada di komunitas.
- c. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi pandangandari tokoh kunci di masyarakat
- d. Studi literature digunakan untuk mengumpulkan data sekunder tentang statistik vital di komunitas yang diperoleh dari dokumen kader, desa, puskesmas, dinas, buku, jurnal
- e. Fokus Group Discussion digunakan untuk mengidentifikasi fenomena spesifik, menyangkut sekelompok orang yang lebih efektif dengan metode diskusi.

2. DIAGNOSIS KEPERAWATAN KOMUNITAS

Data yang telah dikumpulkan pada tahap pengkajian, selanjutnya dianalisis dan dirumuskan dalam diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinik tentang respon individu, keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual atau potensial, sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan perawat. Semua diagnosis keperawatan harus didukung oleh data. Data diartikan sebagai definisi karakteristik. Rumusan diagnosis keperawatan keluarga ada empat jenis, yaitu aktual, risiko, promosi kesehatan dan sejahtera (NANDA, 2018).

Terdapat beberapa diagnosa keperawatan komunitas yang sering terjadi pada masalah kesehatan TB Paru, diantaranya yaitu:

1. Perilaku cenderung berisiko: ditandai dengan perilaku yang perilaku maladaptif yang dilakukan oleh populasi, namun belum terjadi masalah kesehatan.
2. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan: ditandai dengan data-data mengarah pada masalah yang sudah terjadi, tetapi populasi kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan dasar.
3. Defisiensi kesehatan komunitas: ditandai dengan adanya atau satu lebih masalah kesehatan atau factor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi.
4. Ketidakefektifan manajemen kesehatan: ditandai dengan populasi/kelompok sudah mengetahui program terapi yang harus dilakukan, akan tetapi kelompok tidak menjalankan program terapi sesuai pengetahuan yang dimiliki.

3. INTERVENSI KEPERAWATAN KOMUNITAS

Penyusunan rencana keperawatan ditujukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan kelompok/komunitas. Rencana keperawatan dikomunikasikan dengan tim kesehatan untuk meningkatkan pendekatan ketika bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perencanaan keperawatan komunitas terdiri dari, penetapan tujuan, kriteria hasil yang spesifik, dan rencana tindakan keperawatan.

Penempatan rencana asuhan keperawatan komunitas mengikuti pilihan bersama yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Intervensi keperawatan menurut Model *Community as Partner* (Anderson & McFarlane, 2011) dapat disusun dengan pendekatan prevensi primer, sekunder dan tersier.

- a. Prevensi primer: Ditujukan pada kelompok/komunitas yang sehat Bentuk intervensi prevensi primer dapat berupa tindakan promosi, pencegahan dan proteksi kesehatan. Contohnya antara lain pendidikan kesehatan, imunisasi, vaksinasi, monitoring kebijakan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Prevensi sekunder: Ditujukan pada kelompok/komunitas yang mengalami masalah kesehatan masyarakat. Bentuk intervensi prevensi sekunder yang dapat dilakukan berupa deteksi dini masalah kesehatan dan pemberian terapi keperawatan komunitas yang sesuai. Contohnya seperti skrining/survatlans kesehatan, konsultasi, konseling, manajemen kasus dan lingkungan, serta kunjungan rumah.
- c. Prevensi tersier: Ditujukan pada kelompok/ komunitas yang berada pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan masyarakat. Bentuk intervensi prevensi tersier adalah tindakan rehabilitasi kesehatan masyarakat misalnya layanan kesehatan rujukan dan follow up, peningkatan system dukungan dan pengembangan program kesehatan masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan pada keperawatan komunitas dapat dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, dan kuratif kepada msyarakat.

- a. Promotif: Pelayanan keperawatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan komunitas pada umumnya, seperti: Penyediaan makanan dengan kandungan nutrisi seimbang, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, pendidikan kesehatan, olah raga, dan usaha kesehatan jiwa.
- b. Preventif: Tindakan keperawatan untuk mencegah kejadian penyakit pada komunitas, seperti: vaksinasi, imunisasi, isolasi penderita penyakit menular, dan pencegahan kejadian kecelakaan baik di fasilitas umum maupun di tempat kerja.
- c. Kuratif: Upaya mengidentifikasi dan mengetahui jenis penyakit pada fase awal serta melakukan tindakan perawatan dan atau pengobatan yang tepat dan segera. Tujuan utama upaya kuratif antara lain: Pengobatan sedini mungkin dan tepat untuk mencegah kecacatan/kematian, pencegahan penularan pada inivididu/komunitas yang sehat.
- d. Rehabilitatif: Tindakan pemulihan agar fungsi kesehatan klien kemma-li pulih seperti sebelum sakit. Apabila terjadi kecacatan, maka dilakukan upaya kesehatan agar tidak gejala sisa dan dapat berfungsi optimal sesuai kemampuannya. Rehabilitasi dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi fisiologis, mental dan sosial klien semaksimal mungkin.

4. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN KOMUNITAS

Tahap implementasi adalah suatu tahap mencapai sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal yang sangat penting dalam implementasi keperawatan kesehatan komunitas adalah melakukan tindakan yang berupa promosi kesehatan, memelihara kesehatan/mengatasi kondisi yang tidak sehat, mencegah penyakit dan dampak pemulihan. Tahapan implementasi keperawatan komunitas memiliki beberapa strategi implementasi diantaranya yaitu pendidikan kesehatan, proses kelompok, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan intervensi profesional.

1. Pemberdayaan masyarakat: Dilakukan dalam bentuk dukungan, dorongan, dan pengetahuan baru yang bertujuan agar masyarakat terlibat aktif dalam masalah kesehatan yang dialaminya.
2. Pendidikan kesehatan: Dilakukan untuk menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat menjadi sadar, tahu dan mengerti, mau serta dapat melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan.
3. Proses kelompok: Dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Berkaitan dengan pengembangan kesehatan masyarakat yang relevan, maka mencoba menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat dengan model pengembangan masyarakat (*community development*).
4. Intervensi profesional: Dilakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di komunitas melalui penerapan kompetensi yang dimiliki oleh perawat.
5. Kerjasama/kemitraan: Dilakukan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam menyelesaikan masalah komunitas. Kemitraan antara perawat komunitas dan pihak-pihak terkait dengan masyarakat digambarkan dalam bentuk garis hubung antara komponen-komponen yang ada. Hal ini memberikan pengertian perlunya upaya kolaborasi dalam mengkombinasikan keahlian masing-masing yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi peningkatan kesehatan masyarakat.
6. Intervensi Profesional: Salah satu bentuk intervensi langsung perawat kepada klien di keluarga ataupun pada kelompok dengan menggunakan kemampuan profesional dalam bentuk intervensi keperawatan mandiri. Pelayanan keperawatan kesehatan komunitas diberikan kepada klien dengan berpedoman kode etik keperawatan. Kode etik mencerminkan penerapan beberapa prinsip etik yang harus dipatuhi oleh perawat ketika melakukan praktik antara lain: *Justice, autonomy, beneficence, non-maleficence, veracity, dan confidentiality*.

5. EVALUASI KEPERAWATAN KOMUNITAS

Evaluasi adalah proses membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan

terhadap relevansi, keefektifan biaya dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan komunitas dalam mencapai tujuan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan kelompok/komunitas berdasarkan respon kelompok komunitas terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan:

- a. Mengakhiri rencana tindakan: Klien telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
- b. Memodifikasi rencana tindakan: Klien mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan.
- c. Meneruskan rencana tindakan: Klien memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan.

Jenis evaluasi keperawatan komunitas yang bisa diterapkan menurut waktu pelaksanaan kegiatan.

- a. Formatif (Proses) dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program yang bertujuan memperbaiki pelaksanaan program dan kemungkinan adanya temuan utama berupa berbagai masalah dalam pelaksanaan program.
- b. Sumatif (Hasil) merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program dan capaian dari pelaksanaan program.

Prinsip-prinsip evaluasi keperawatan komunitas meliputi: 1) penguatan program; 2) menggunakan berbagai pendekatan; 3) desain evaluasi untuk kriteria penting dikomunitas; 4) menciptakan proses partisipasi; 5) diharapkan lebih fleksibel; dan 6) membangun kapasitas.

"Jangan berhenti belajar sampai kamu merasa bangga dengan hasilnya."

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. T. dan J. McFarlane. 2014. *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*. *Community as Partner: Theory and Practice in Nursing*.
- Anderson, E. T. dan M. Judith. 2011. *Community As Partner : Theory and Practice in Nursing*. Edisi 6. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Fang, X.-H., Shen, H.-H., Hu, W.-Q., Xu, Q.-Q., Jun, L., Zhang, Z.-P., Kan, X.-H., Ma, D.-C., & Wu, G.-C. (2019). Prevalence of and factors influencing anti-tuberculosis treatment non-adherence among patients with pulmonary tuberculosis: A cross-sectional study in Anhui Province, Eastern China. *Medical Science Monitor*, 25, 1928–1935. <https://doi.org/10.12659/MSM.913510>
- Gebreweld, F. H., Kifle, M. M., Gebremicheal, F. E., Simel, L. L., Gezae, M. M., Ghebreyesus, S. S., Mengsteab, Y. T., & Wahd, N. G. (2018). Factors influencing adherence to tuberculosis treatment in Asmara, Eritrea: A qualitative study. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 37(1). <https://doi.org/10.1186/S41043-017-0132-Y>
- Health Office of East Java Province. (2020). *Health Profile of East Java Province 2019*.
- Health Office of Jember. (2021). *Tuberculosis Data in Jember Regency in 2021*.
- Indonesia Ministry of Health. (2016). *PMK no. 67 about Tuberculosis Control*. [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 67 ttg Penanggula ngan Tuberkolosis .pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._67_ttg_Penanggula_ngan_Tuberkolosis_.pdf)
- Indonesia Ministry of Health. (2020). *Indonesia Health Profile 2019*.
- Indonesia Ministry of Health. (2021). *Indonesia Health Profile 2021*.
- Nanda. 2018. *Diagnosis Keperawatan Definisi & Klasifikasi 2018-2020 Edisi 11* Editor T Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru. Jakarta: EGC.
- Ruru, Y., Matasik, M., Oktavian, A., Senyorita, R., Mirino, Y., Tarigan, L. H., van der Werf, M. J., Tiemersma, E., & Alisjahbana, B. (2018). Factors associated with non-adherence during tuberculosis treatment among patients treated with DOTS strategy in Jayapura, Papua Province, Indonesia. *Global Health Action*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1510592>
- World Health Organization. (2021). *Global tuberculosis report 2021*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021>

Yang, S. H., Jung, E. Y., & Yoo, Y. S. (2020). Health literacy, knowledge and self-care behaviors in patients with pulmonary tuberculosis living in community. *Journal of the Korean Academy of Fundamentals of Nursing*, 27(1), 1–11.
<https://doi.org/10.7739/jkafn.2020.27.1.1>

SINOPSIS BUKU

Judul Buku : Asuhan Keperawatan Komunitas Berdasarkan Tinjauan 3N & 3S
(dilengkapi dengan Konsep Penyakit dan Contoh Kasus)
Penulis pertama : Ns. T. Widya Naralia, M.Kep., Sp.Kep.K
Email Penulis : widya.naralia@gmail.com
Penerbit : _____
Tahun, Tempat Terbit : 2023, Jakarta
Cetakan Ke : _____
Tebal : 75 Halaman

Keperawatan Komunitas adalah salah satu bidang ilmu keperawatan dimana praktiknya dilakukan di masyarakat, baik pada individu, keluarga maupun kelompok dengan tujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Perawat di komunitas terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat sangat membutuhkan buku ini sebagai pedoman penerapan asuhan keperawatan dengan berbagai kasus di masyarakat. Tidak hanya itu, buku ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa maupun dosen keperawatan yang ingin mendalami tentang penulisan asuhan keperawatan komunitas serta mengaplikasikan intervensi keperawatan komunitas.

Buku “Asuhan Keperawatan Komunitas Berdasarkan Tinjauan 3N & 3S (dilengkapi dengan Konsep Penyakit dan Contoh Kasus)” ini ditulis oleh empat orang ahli keperawatan komunitas mencakup teori dan konsep berbagai penyakit. Buku ini menjabarkan 4 asuhan keperawatan komunitas yaitu pada agregat lansia dengan diabetes mellitus, agregat anak dengan defisiensi zat besi, agregat dewasa dengan gagal ginjal kronik, dan agregat dewasa dengan tuberkulosis. Setiap topik dijabarkan dengan rinci mulai dari konsep penyakit masing-masing kemudian pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi sesuai dengan masalah kesehatan pada agregat tersebut.

Penerapan asuhan keperawatan pada buku ini ada yang berdasarkan pada 3N yaitu NANDA, NOC dan NIC serta ada yang berdasarkan 3S yaitu SDKI, SLKI dan SIKI. Buku ini telah dilengkapi dengan referensi yang jelas dan valid. Harapannya buku ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh pembacanya serta memberikan dampak baik kepada masyarakat khususnya di Indonesia.

Keperawatan Komunitas adalah salah satu bidang ilmu keperawatan dimana praktiknya dilakukan di masyarakat, baik pada individu, keluarga maupun kelompok dengan tujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Perawat di komunitas terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat sangat membutuhkan buku ini sebagai pedoman penerapan asuhan keperawatan dengan berbagai kasus di masyarakat. Tidak hanya itu, buku ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa maupun dosen keperawatan yang ingin mendalami tentang penulisan asuhan keperawatan komunitas serta mengaplikasikan intervensi keperawatan komunitas.

Buku “Asuhan Keperawatan Komunitas Berdasarkan Tinjauan 3N & 3S (dilengkapi dengan Konsep Penyakit dan Contoh Kasus)” ini ditulis oleh empat orang ahli keperawatan komunitas mencakup teori dan konsep berbagai penyakit. Buku ini menjabarkan 4 asuhan keperawatan komunitas yaitu pada agregat lansia dengan diabetes mellitus, agregat anak dengan defisiensi zat besi, agregat dewasa dengan gagal ginjal kronik, dan agregat dewasa dengan tuberkulosis. Setiap topik dijabarkan dengan rinci mulai dari konsep penyakit masing-masing kemudian pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi sesuai dengan masalah kesehatan pada agregat tersebut.

Penerapan asuhan keperawatan pada buku ini ada yang berdasarkan pada 3N yaitu NANDA, NOC dan NIC serta ada yang berdasarkan 3S yaitu SDKI, SLKI dan SIKI. Buku ini telah dilengkapi dengan referensi yang jelas dan valid. Harapannya buku ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh pembacanya serta memberikan dampak baik kepada masyarakat khususnya di Indonesia.

Penerbit :

PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919

ISBN 978-623-09-3557-2

